Boletín Epidemiológico N° 23 de 2025

Dirección de Vigilancia de la Salud

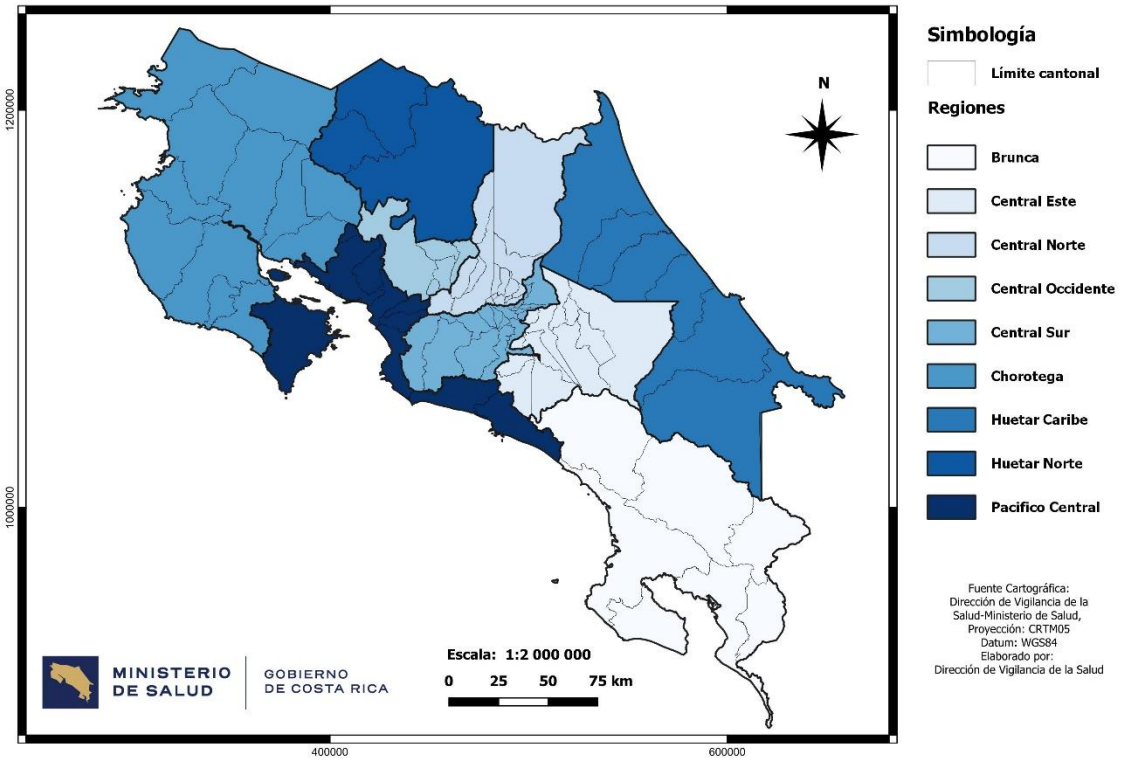
Ministerio de Salud

27 de junio de 2025

Tabla de contenido

Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 24 .. 3
Malaria 4
Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19 12
Sarampión 28
Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 33
Meningitis 35
Infecciones de transmisión sexual 39
Miasis por gusano barrenador en humanos 51
Casos notificados de violencia intrafamiliar 58

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024



Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 24

Rodrigo Marín Rodríguez
Programa de Control de Vectores
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud.

Rose Mary Hidalgo Ríos
Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM)

En la siguiente tabla se desglosan las acciones de control vectorial que se han realizado en la Semana Epidemiológica 24 del 2025, por el personal de Control de Vectores del país.

Cuadro 1.
Costa Rica: Acciones de control vectorial en la Semana Epidemiológica 24

	Total
Viviendas visitadas	**12.481**
Viviendas positivas	**985**
Depósitos tratados	**45.365**
Depósitos eliminados	**35.690**
Depósitos positivos	**1.902**
Viviendas fumigadas	**12.510**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Así mismo se detalla lo que llevamos de la Semana Epidemiológica 1 a la 24.

	Total
Viviendas visitadas	**297.484**
Viviendas positivas	**11.960**
Depósitos tratados	**1.091.035**
Depósitos eliminados	**777.395**
Depósitos positivos	**20.539**
Viviendas fumigadas	**277.445**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Malaria

Isaac Vargas Roldán
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Sarah Arce Bonilla
Dirección de Vigilancia de la Salud

I. Antecedentes

Costa Rica ha logrado mantener bajos niveles de transmisión de malaria gracias a los esfuerzos continuos y control. Los casos han disminuido notablemente en comparación con el pasado.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) lideran los esfuerzos de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de la malaria, junto con el apoyo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). Se utilizan herramientas para el diagnóstico rápido y monitoreo constante de los casos.

Costa Rica forma parte de la **Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana (IREM)** es un esfuerzo conjunto de varios países y organizaciones internacionales con el objetivo de eliminar la malaria en esta región. Esta iniciativa busca coordinar acciones, compartir recursos y conocimientos, y establecer estrategias comunes para combatir y erradicar esta enfermedad.

El objetivo principal para este año es mantener la reducción sostenida de casos de malaria y avanzar hacia la meta de eliminación. Costa Rica se perfila como el próximo país de la región en obtener la certificación de cero casos autóctonos de malaria.

Como parte de las acciones para alcanzar este objetivo, se están llevando a cabo **supervisiones capacitantes** dirigidas a los funcionarios de la CCSS y el MINSA. Estas supervisiones tienen el propósito de actualizarlos en el manejo de la malaria y fortalecer la implementación de estrategias de control, como la estrategia DTIR, en todo el territorio nacional.

Además, se está priorizando el **fortalecimiento de la red de colaboradores voluntarios** en comunidades con barreras de acceso a los servicios de salud y esfuerzos para acerca el diagnóstico y tratamiento a personas en condición de movilidad humana que llevan su paso por el país.

II. Vigilancia epidemiológica

El histórico de transmisión local de malaria presenta los casos registrados en los años 2023, 2024 y 2025, organizados por semana epidemiológica. Se observa una tendencia general a la disminución de casos en el periodo analizado.

Durante el periodo comprendido entre las semanas epidemiológicas 1 a 24, se observa una disminución progresiva en el número de casos de transmisión local de malaria a lo largo de los últimos tres años. En el año 2023, se registraron 341 casos, mientras que en 2024 la cifra se redujo a 151 casos, lo que representa una disminución del 56%. En lo que va del año 2025, se han reportado 6 casos, lo que equivale a una reducción del 98% en comparación con el mismo periodo de 2023.

Adicionalmente, en lo que va del año 2025 se ha 1 caso introducido en Santa Rosa de Pocosol y se han detectado 14 casos importados de malaria, siento el 79% *P. vivax* (N=11) y 21% *P.falciparum* (N=3) cuya transmisión ocurrió fuera del país. Estos casos fueron identificados en las localidades de San Pablo (Nandayure), San Ramón (San Ramón), Corredores, Pavas (San José), Cutris (San Carlos) y Los Chiles. Las personas afectadas se desempeñan principalmente como operarios de construcción, peones agrícolas y coligalleros, y además personas que se encuentran en condición de movilidad humana, provenientes de Nicaragua, ruta migratoria desde América del Sur y de retorno desde México y Gabón, África.

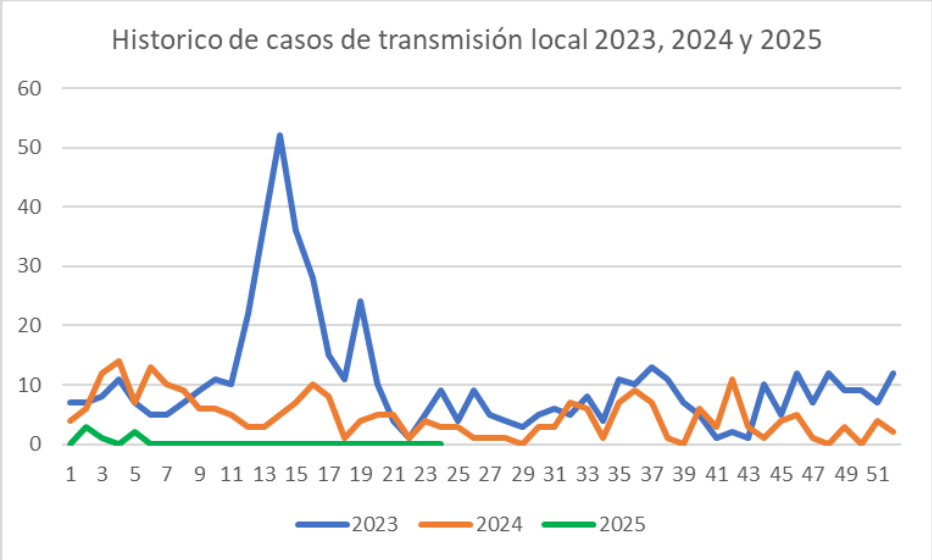
Tabla 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE22.

Histórico Transmisión local			
Semana Epidemiológica	2023	2024	2025
1	7	4	0
2	7	6	3
3	8	12	1
4	11	14	0
5	7	7	2
6	5	13	0
7	5	10	0
8	7	9	0
9	9	6	0

10	11	6	0
11	10	5	0
12	22	3	0
13	37	3	0
14	52	5	0
15	36	5	0
16	28	7	0
17	15	8	0
18	11	1	0
19	24	4	0
20	10	5	0
21	4	5	0
22	1	1	0
23	5	4	0
24	9	3	0
Total	**341**	**151**	**6**

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Gráfico 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE 24.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Producción de pruebas de diagnóstico

Se ha llevado a cabo un exhaustivo monitoreo a nivel nacional de la malaria, por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud realizando pruebas de diagnóstico mediante búsquedas pasivas y activas de casos.
A semana epidemiológica 24, se registraron 61.039 pruebas de diagnóstico, las cuales responden a las búsquedas realizadas por las instituciones, desglosadas de la siguiente manera, (refiérase a la figura 1):

- **Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por el Ministerio de Salud**: 27.813, referirse a la tabla 2.
    - **Colaboradores Voluntarios**: 626
    - **Inspectores de Salud**: 27.187

- **Pruebas de diagnóstico realizadas por CCSS**: 33.226, referirse al gráfico 3.
    - **Gotas gruesas**: 5.775
    - **Pruebas de diagnóstico rápido**: 27.094
    - **PCR**: 357

Estas cifras reflejan un esfuerzo coordinado y continuo para identificar y controlar la propagación de la malaria en el país. La combinación del método tradicional como lo es la gota gruesa y las pruebas rápidas permite una detección más amplia y oportuna de casos, contribuyendo significativamente a la vigilancia epidemiológica y al manejo efectivo de esta enfermedad.

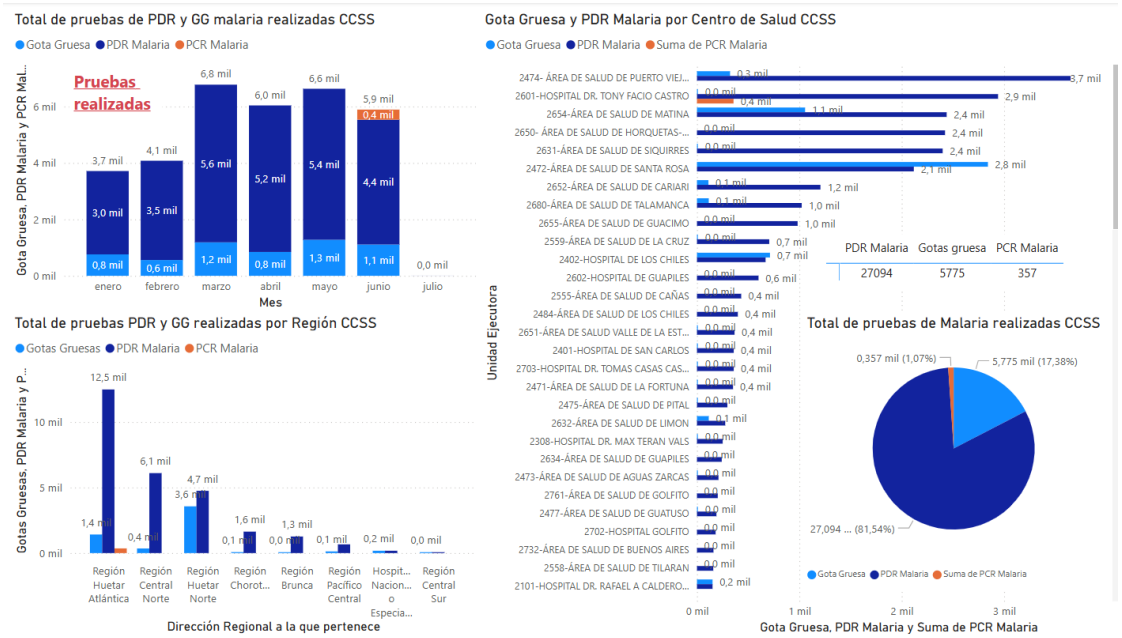
Nota: El registro puede incluir datos duplicados, ya que se toman en cuenta las Gotas Gruesas (GG) para cuantificar la parasitemia antes de iniciar el tratamiento, ante una Prueba de Diagnóstico Rápido (PDR) positiva.

Tabla 2.
Costa Rica: Vigilancia generada por inspectores de salud y voluntarios

Región	Pruebas realizadas por Inspectores de Salud	Pruebas realizadas por voluntarios
Brunca	11369	51
Central Norte	116	28
Chorotega	2780	72
Huetar Caribe	5279	199
Huetar Norte	6590	250
Pacífico Central	1053	26
Total	27187	626

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Gráfico 3.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS.



Fuente: CCSS.

Tabla 2.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS por región

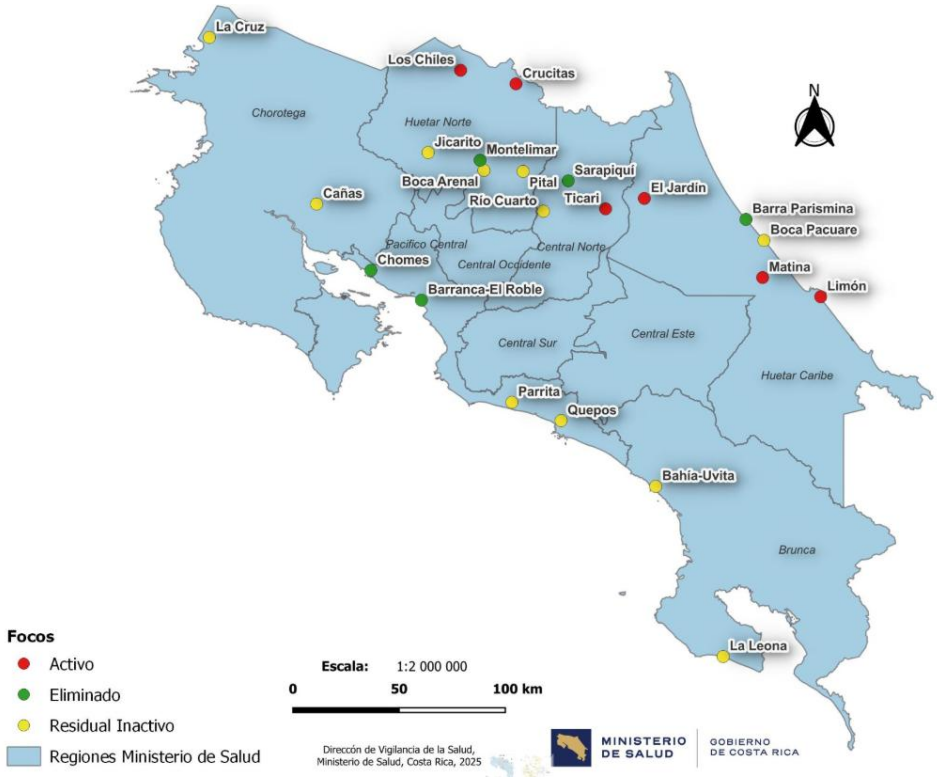
Región	Suma de Total de PDR realizadas	Suma de Total de Gotas gruesas analizadas
Región Huetar Atlántica	12477	1418
Región Central Norte	6098	352
Región Huetar Norte	4748	3565
Región Chorotega	1636	73
Región Brunca	1264	31
Región Pacífico Central	666	128
Hospitales Nacionales o Especializados	179	178
Región Central Sur	26	30
Total general	**27094**	**5775**

Fuente: CCSS.

III. Inventario de focos.

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 6 focos activos, 10 focos residuales inactivos y 5 focos eliminados.

Figura 1.
Costa Rica: Inventario de focos de Malaria a mayo 2025.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

IV. Clasificación del estado histórico y actual de los focos maláricos.

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

Tabla 3.
Costa Rica: Listado de Focos de malaria a Enero 2025, por provincia, cantón y estado actual del foco.

Provincia	Cantón	Nombre del Foco	Estado
Alajuela	San Carlos	Pital	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Boca Arenal	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Monterrey	Eliminado
Alajuela	San Carlos	Crucitas - Llano Verde	Activo
Alajuela	Los Chiles	Los Chiles	Activo
Alajuela	San Carlos	Jicarito	Residual inactivo
Alajuela	Río Cuarto	Rìo Cuarto	Residual inactivo
Guanacaste	La Cruz	La Cruz	Residual inactivo
Guanacaste	Cañas	Cañas	Residual inactivo
Heredia	Sarapiquí	Sarapiquí	Eliminado
Heredia	Sarapiquí	Ticari	Activo
Limón	Matina	Matina	Activo
Limón	Limón	Limón	Activo
Limón	Siquirres	Barra de Parismina	Eliminado
Limón	Pococí	El Jardín	Activo
Limón	Siquirres	Barra Pacuare	Residual inactivo
Puntarenas	Roble	El Roble	Eliminado
Puntarenas	Puntarenas	Chomes	Eliminado
Puntarenas	Quepos	Quepos	Residual inactivo
Puntarenas	Parrita	Parrita	Residual inactivo
Puntarenas	Golfito	La Leona	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	Bahia Uvita	Residual inactivo

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19

Roberto Arroba Tijerino
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Mayra Quesada Sanabria
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

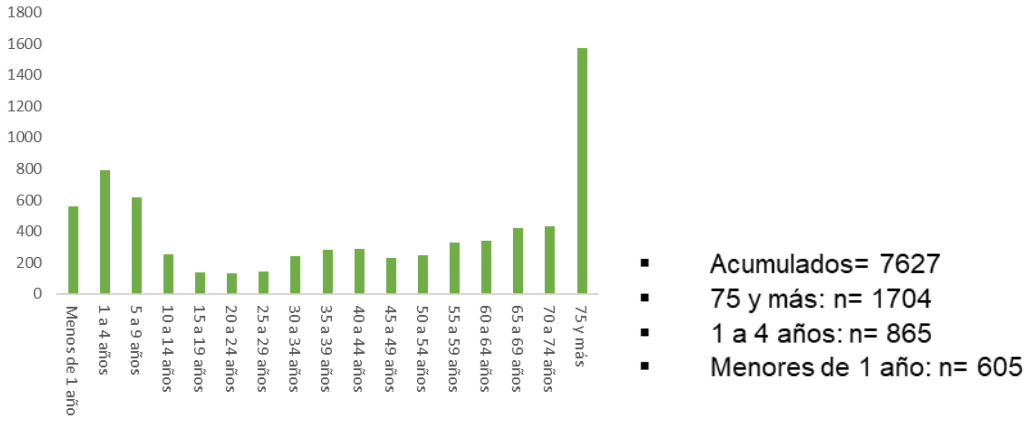
Rafael Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos para la semana epidemiológica 24 de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) y los datos de la semana epidemiológica 24 de las Infecciones Respiratorias Agudas Superiores (IRAS) y la Enfermedad Tipo Influenza (ETI), que según establece el Decreto de Vigilancia de la Salud No. 40556-S del 07 julio del 2017, son eventos de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de las IRAG, por medio de la boleta VE-01, se cuenta con los siguientes datos:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 24 son un total de 7627.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en los niños entre 1 y 4 años y en los mayores de 75 años.

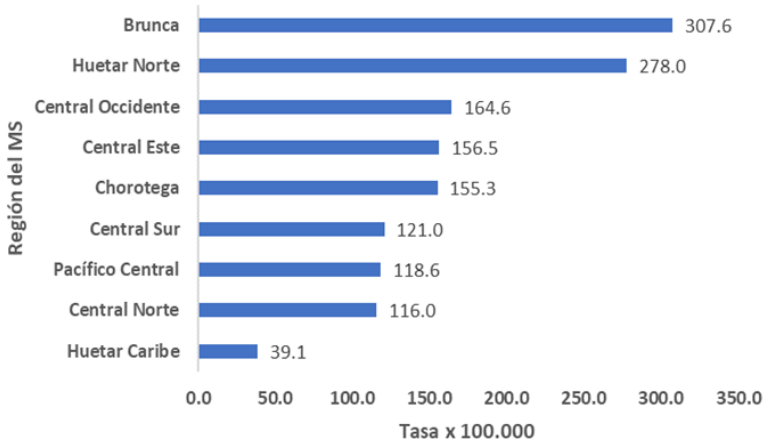
Gráfico 1.
Distribución de casos de IRAG por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 24, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según el gráfico 1, se puede apreciar como en los extremos de la vida (niños entre 1 y 4 años y mayores de 75 años es donde más casos se han presentado).
En el gráfico 2, se observa la tasa de incidencia de IRAG según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 24, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Brunca y la Huetar Norte; las regiones con menor incidencia corresponden a la Chorotega, Central Este, Central Occidente, Central Sur, Central Norte, Pacífico Central y Huetar Caribe.

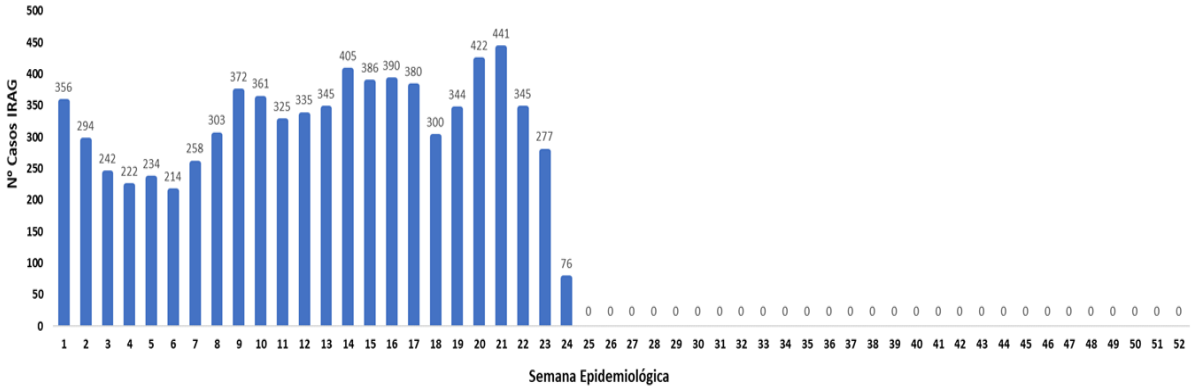
Gráfico 2.
Tasa de IRAG según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 24 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-01 de IRAG, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 3; se puede observar el comportamiento de los casos a la semana epidemiológica 24 del año 2025.

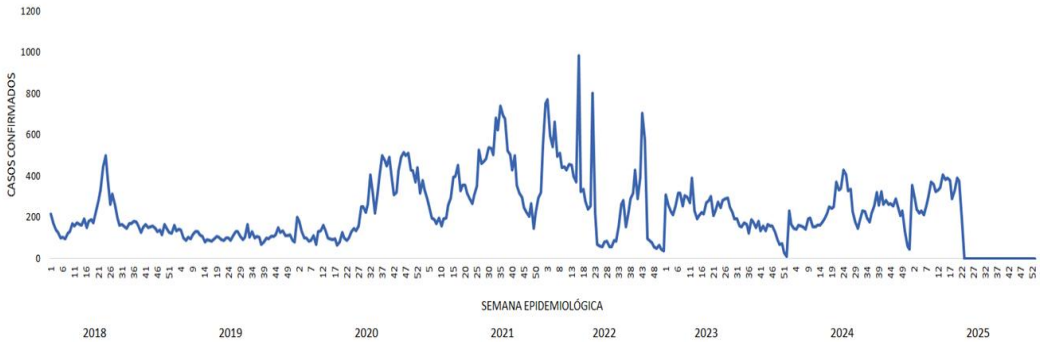
Gráfico 3.
Distribución de casos reportados por boleta VE-01 de IRAG a la semana epidemiológica 24, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAG, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 4.

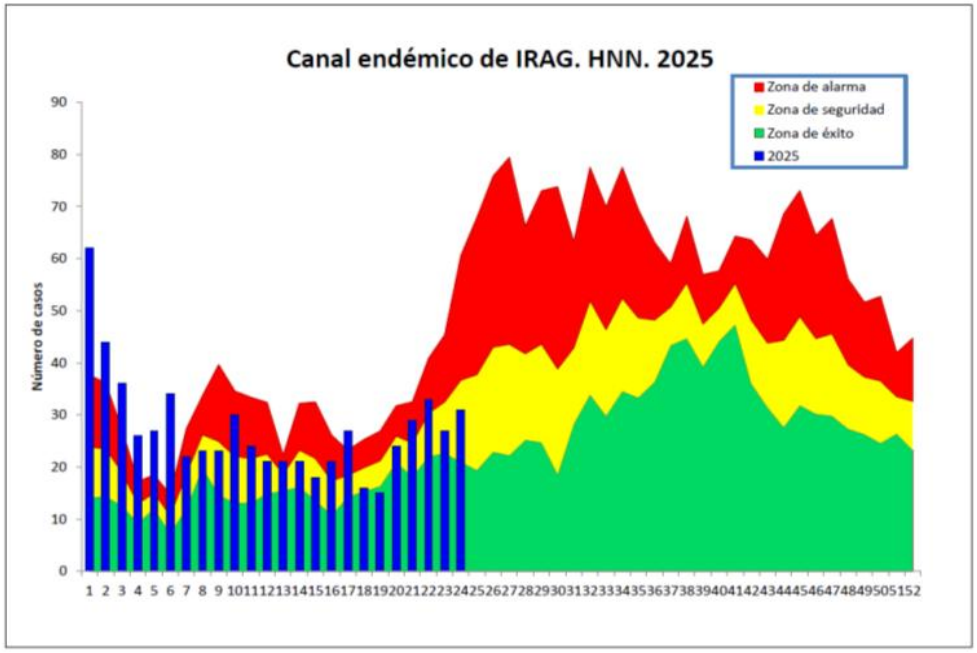
Gráfico 4.
Distribución histórica de casos de IRAG por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

El HNN, para la SE-24 tiene un canal endémico de IRAG que actualmente se encuentra por en zona de seguridad, debido a la cantidad de casos que están presentando en este momento, tal como se puede apreciar en el gráfico 5.

Gráfico 5.
Costa Rica: Canal endémico IRAG, HNN, 2025

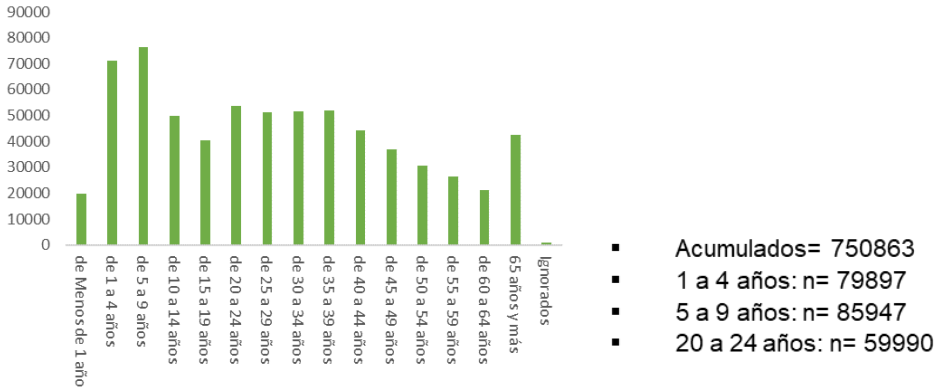


Fuente: EDUS-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de IRAS, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 6:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 24 son 750863.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en menores entre 1 y 4 años y menores entre 5 y 9 años.

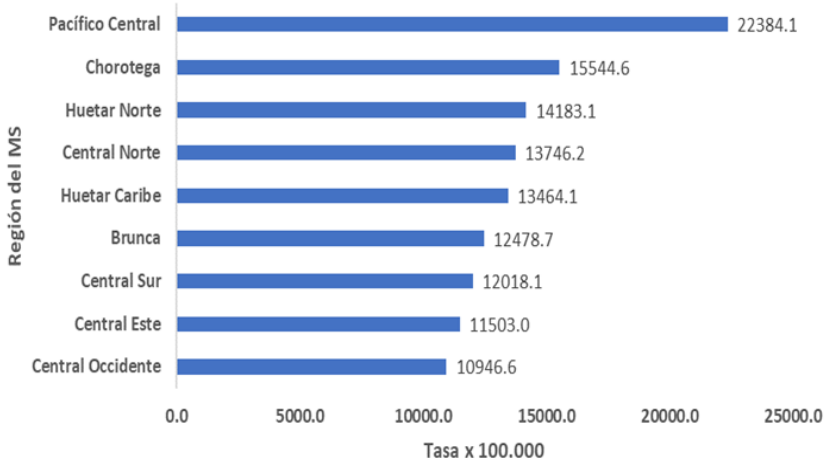
Gráfico 6.
Distribución de casos de IRAS por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 24, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 7, se observa la tasa de incidencia de IRAS según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 24, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Pacífico Central y Chorotega. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Huetar Norte, Central Norte, Huetar Caribe, Brunca, Central Occidente, Central Sur y Central Este.

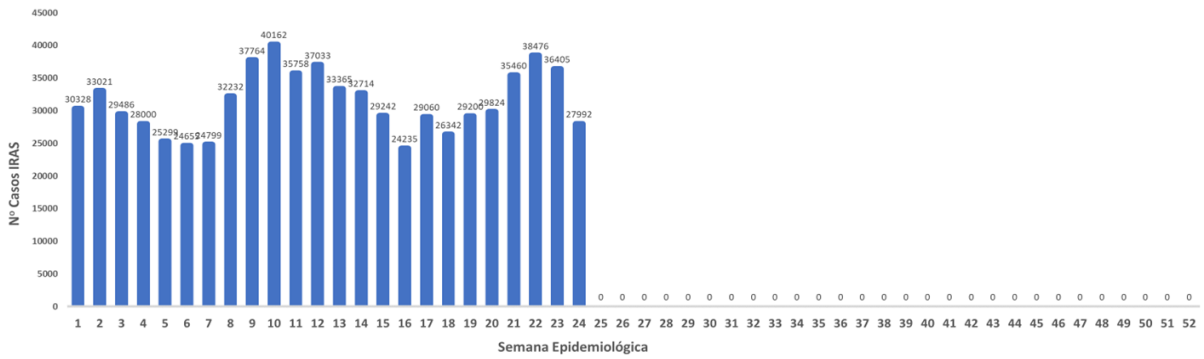
Gráfico 7.
Tasa de IRAS según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 24 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de IRAS, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 8; se puede observar cómo los casos se han comportado a lo largo de estas 24 semanas epidemiológicas del año 2025.

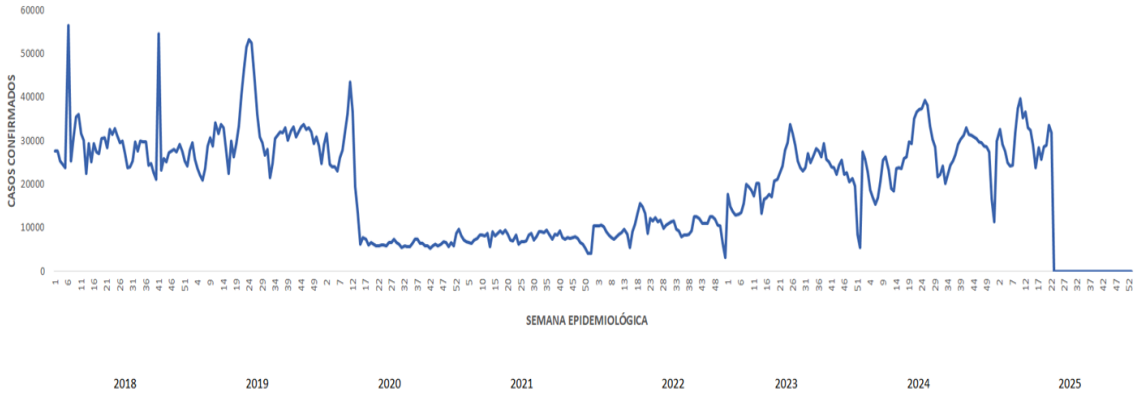
Gráfico 8.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de IRAS a la semana epidemiológica 24, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAS, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 9.

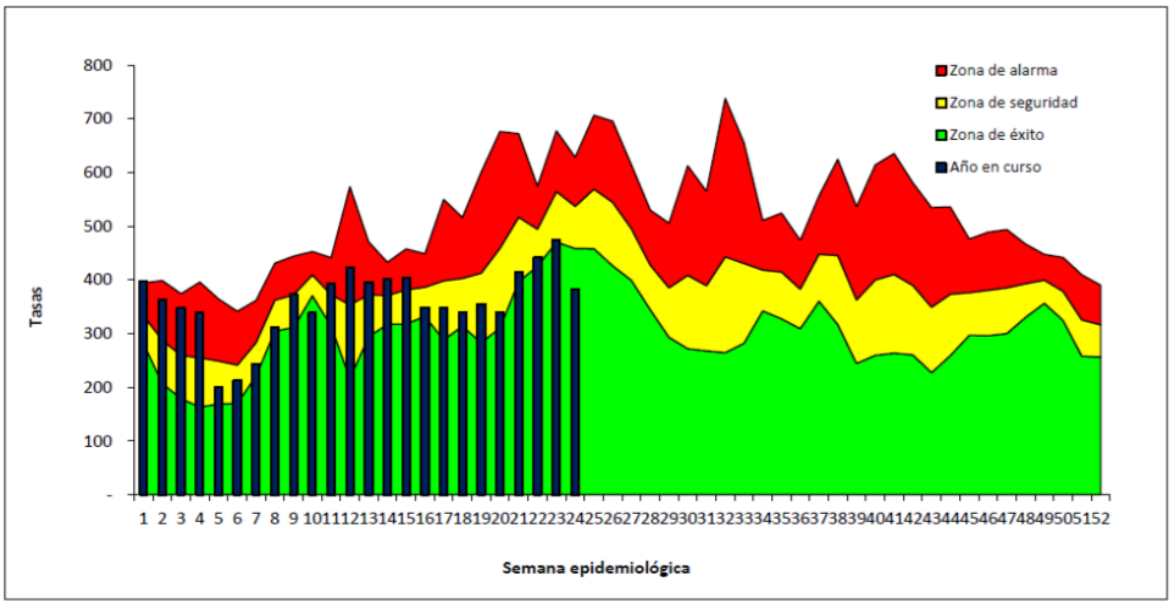
Gráfico 9.
Distribución histórica de casos de IRAS por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 10 se presenta el canal endémico de las IRAS en el Hospital Nacional de Niños, que muestra que a la semana 24 se encuentran en la zona de seguridad actualmente.

Gráfico 10.
Costa Rica: Canal endémico IRAS. HNN. 2025.

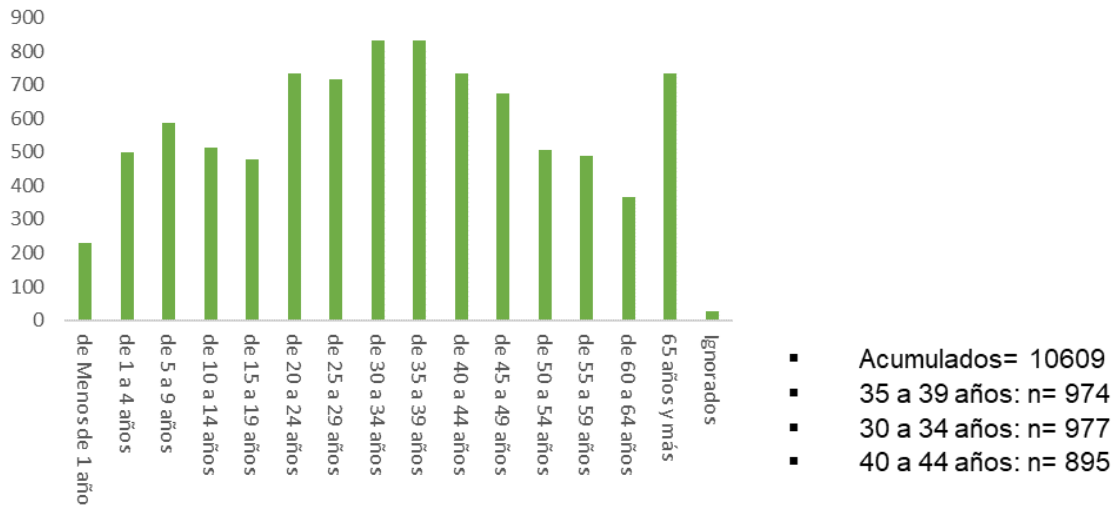


Fuente: Sistemas de Cubos Urgencias-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de ETI, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 11:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 24 son n= 10609.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en personas entre 30 y 34 años y las personas entre 35 y 39 años.

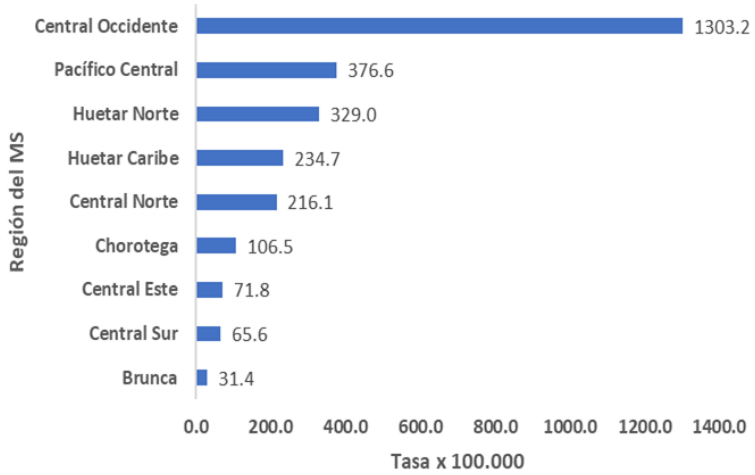
Gráfico 11.
Distribución de casos de ETI por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 24, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 12, se observa la tasa de incidencia por ETI, según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 24, presentando mayor cantidad de casos en la región la Central Occidente. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Brunca, Chorotega, Central Este, Central Sur, Huetar Norte, Pacífico Central, Central Norte y Huetar Caribe.

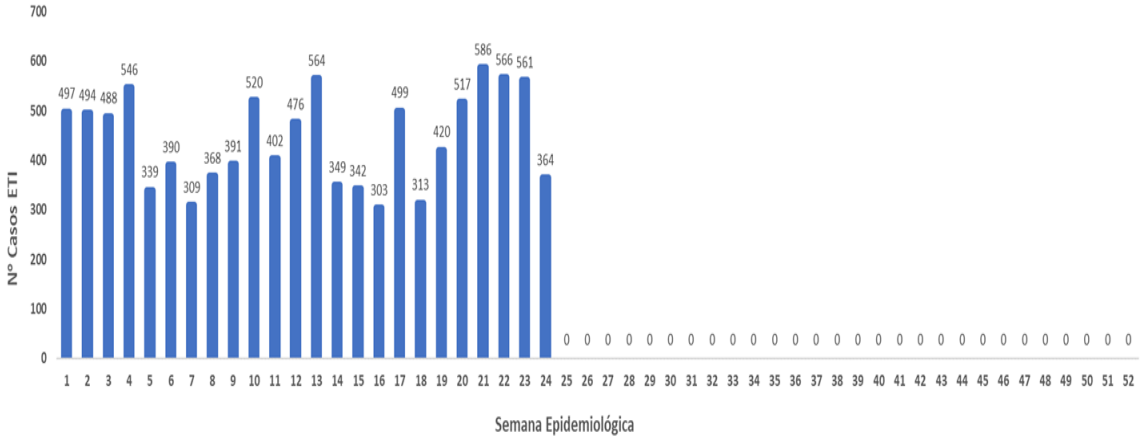
Gráfico 12.
Tasa de ETI por región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 24 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de ETI, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 13; se puede observar cómo se han distribuido los casos en el año 2025.

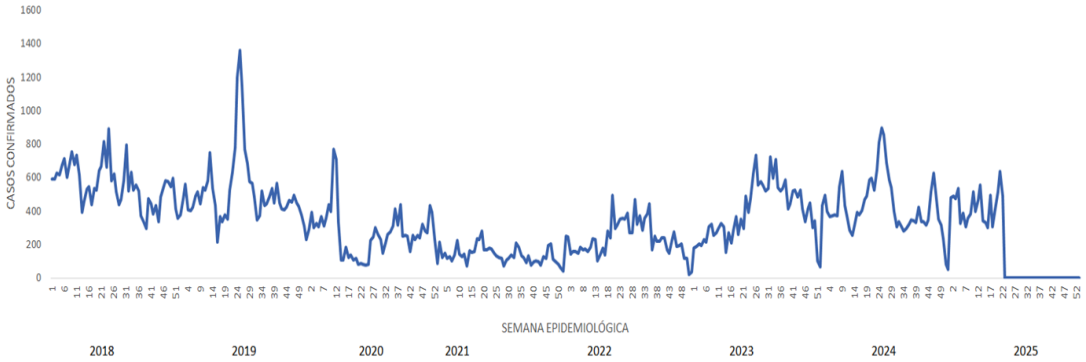
Gráfico 13.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de ETI a la semana epidemiológica 24, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de ETI, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 14.

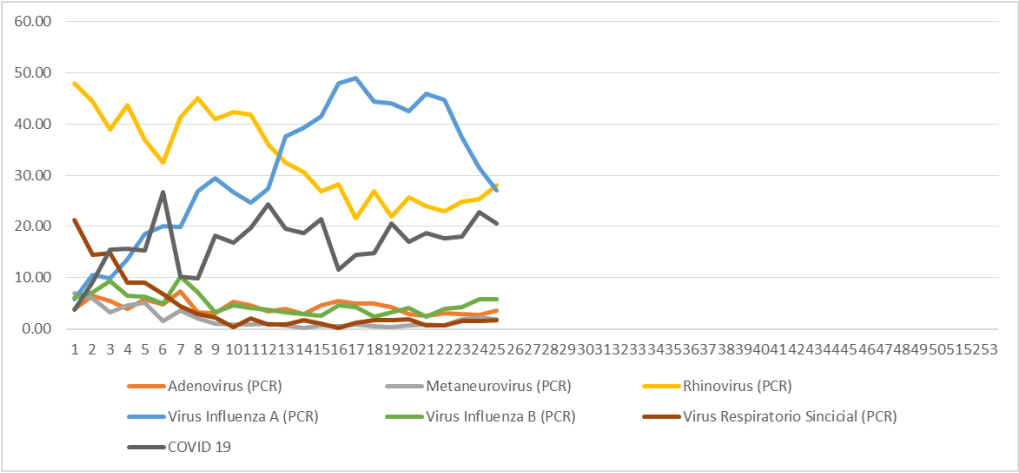
Gráfico 14.
Distribución histórica de casos de ETI por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según se observa en el gráfico 15, se puede ver el comportamiento de los principales virus respiratorios circulantes de la semana 01 a la 25; para la SE-25, en el país el Rinovirus es el que más está circulando, seguido del virus de la Influenza A y finalmente, el Covid-19 está en tercer lugar de circulación.

Gráfico 15.
Distribución de virus circulantes de la semana epidemiológica 01 a la 25 en Costa Rica, 2025.



Fuente: Matriz de Resultados de Laboratorio CCSS, Subárea de Vigilancia Epidemiológica 2025.

En relación con los datos específicos del Hospital Nacional de Niños, la situación que se ha presentado a la semana 26 del año 2025 es la siguiente:
Al 23 de junio del año en curso, correspondiente a la semana 26, el total de pacientes respiratorios hospitalizados son 66, lo que corresponde a un porcentaje de ocupación del 98.5%.

Gráfico 16.
Total de pacientes hospitalizados y en emergencias en la semana 25 del año 2025, Hospital Nacional de Niños.



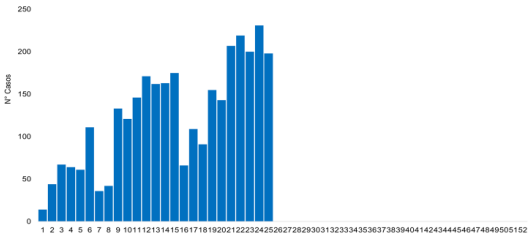
Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2025.

Como observaciones finales se puede indicar lo siguiente:

- IRAG con 7627 casos a la semana 24.
- IRAS con 750863 casos a la semana 24.
- ETI con 10609 casos reportados a la semana 24.
- Actualmente, la ocupación de camas respiratorias en el HNN es de un 98.5%
- En SE-25, el Rinovirus es el virus que más ha circulado, seguido del Virus de Influenza A y en tercer lugar circula el Covid-19.

Para la enfermedad por COVID-19, durante la semana epidemiológica 25, se reportaron un total de 198 casos confirmados, lo que representa una disminución del 14.28% con respecto a la SE-24 del año 2025 que presentó 231 casos.

Gráfico 17.
Costa Rica: Casos COVID-19, según semana epidemiológica año 2025.

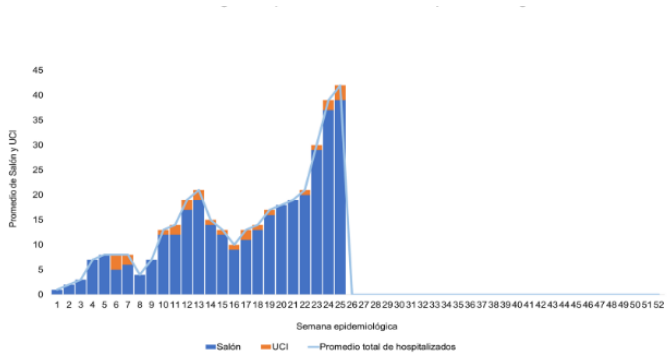


SE	Casos
1	14
2	44
3	67
4	64
5	61
6	111
7	36
8	42
9	133
10	121
11	146
12	171
13	162
14	163
15	175
16	66
17	109
18	91
19	155
20	143
21	207
22	219
23	200
24	231
25	198

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, C.C.S.S / Dirección de Vigilancia de Salud, Ministerio de Salud, 2025.

Con respecto a las hospitalizaciones en la semana epidemiológica 25, se reportó un promedio total de 42 hospitalizados, lo que representa un aumento del 7.7% con respecto a la SE-24 del año 2025 donde se registraron 39 hospitalizaciones.

Gráfico 18.
Costa Rica: Promedio total de hospitalizados en salón y Unidad de Cuidados Intensivos, según reporte semanal año 2025.

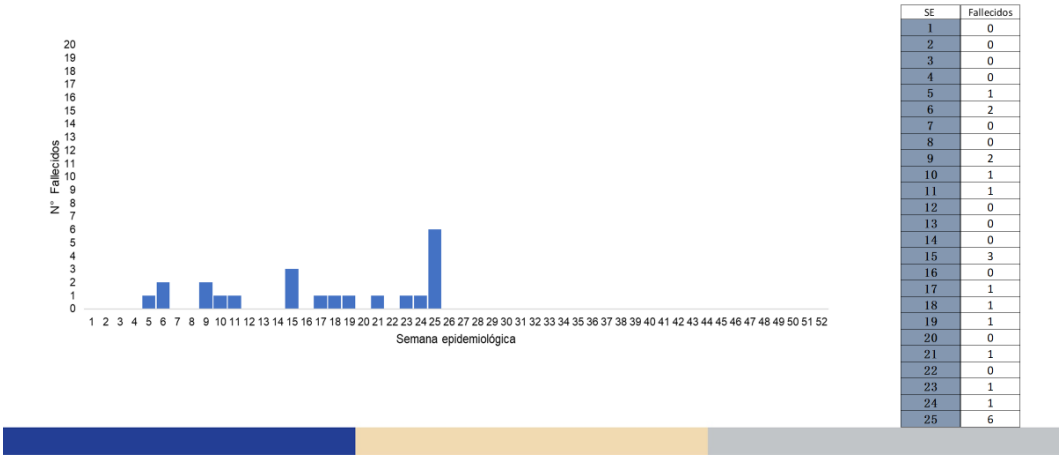


SE	Salón	UCI	Promedio total
1	1	0	1
2	2	0	2
3	3	0	3
4	7	0	7
5	8	0	8
6	5	3	8
7	6	2	8
8	4	0	4
9	7	0	7
10	12	1	13
11	12	2	14
12	17	2	19
13	19	2	21
14	14	1	15
15	12	1	13
16	9	1	10
17	11	2	13
18	13	1	14
19	16	1	17
20	18	0	18
21	19	0	19
22	20	1	21
23	29	1	30
24	37	2	39
25	39	3	42

Fuente: Área de Estadística en Salud, CCSS/Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2025.

En relación con el comportamiento de las personas fallecidas asociadas a COVID-19, durante la semana epidemiológica 25, hubo 6 fallecidos; sin embargo, es importante indicar que estos son datos preliminares sujetos a la revisión de los casos.

Gráfico 19.
Costa Rica: Personas fallecidas asociadas a COVID-19, según reporte semanal año 2025.

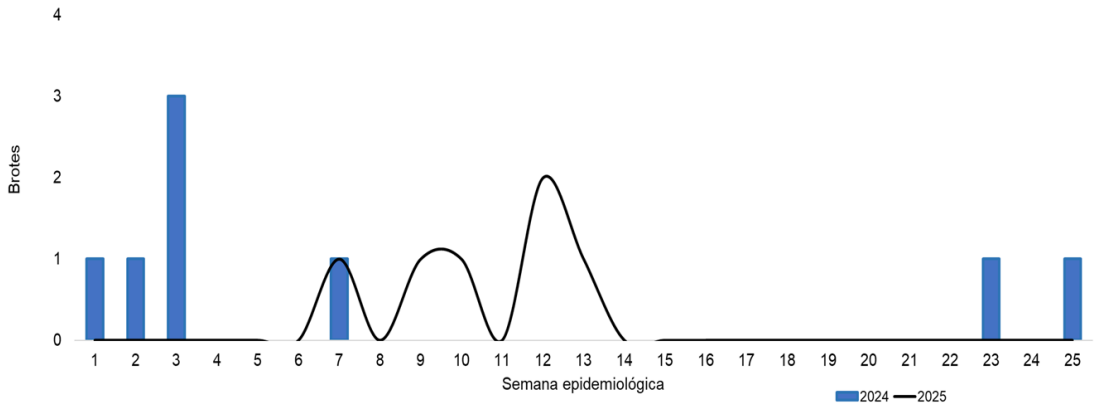


SE	Fallecidos
1	0
2	0
3	0
4	0
5	1
6	2
7	0
8	0
9	2
10	1
11	1
12	0
13	0
14	0
15	3
16	0
17	1
18	1
19	1
20	0
21	1
22	0
23	1
24	1
25	6

Fuente: Área de Estadística en Salud, C.C.S.S. / Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2025.

Para la semana epidemiológica 25 no se reportó ningún brote asociado a COVID-19.

Gráfico 20.
Brotes de covid-19, por semana epidemiológica en Costa Rica, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, 2025.

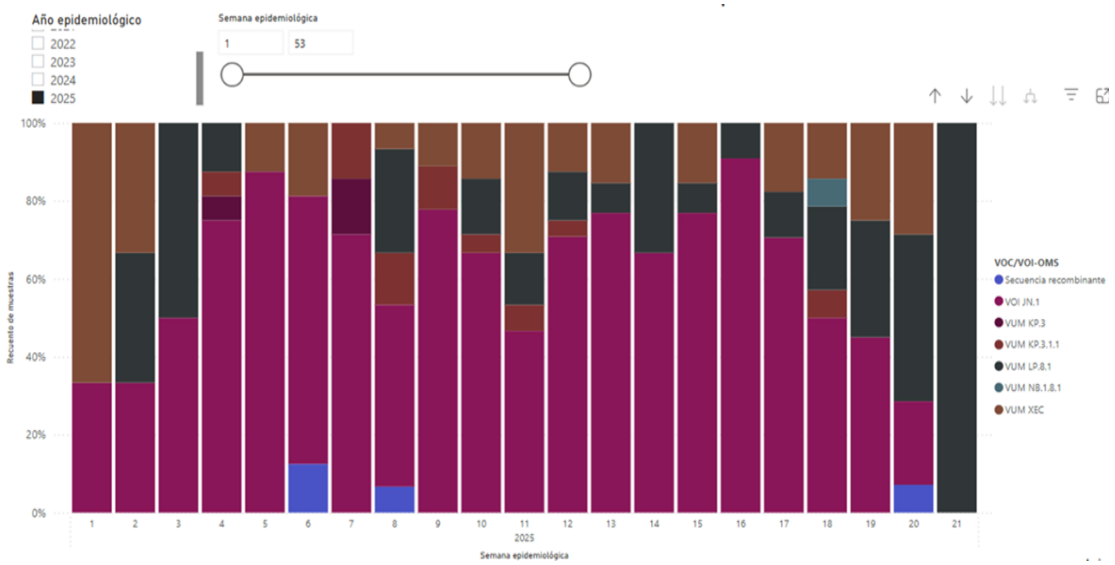
Nota: Se reportaron 24 brotes en el año 2024 y se han reportado 6 brotes en el año 2025

Variantes genómicas

Según el informe interactivo de INCIENSA revisado el 23 de junio del 2025, se reporta lo siguiente.

Gráfico 21.

Costa Rica: Proporción de linaje identificados, para Variante de Preocupación (VOC) Ómicron, Variante de Interés (VOI) y Variantes Bajo Monitoreo (VUM), por semana epidemiológica SE 1-21 del 2025.



Fuente: Sistema de Información de INCIENSA, CCSS, DATOS Facultad de Microbiología UCR, actualizado en informe interactivo en Vigilancia genómica SARS-CoV-2 al 23 de junio del 2025.

En relación con la proporción relativa de sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el periodo comprendido entre la SE-1 y la 21 del año 2025, se tiene la siguiente información.

Cuadro 1.
Costa Rica: Proporción relativa de Sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el período de las semanas epidemiológicas 1-21 del 2025

Linaje Pangolin	Cantidad	%
Secuencia recombinante	4	1.53
VOI JN.1	165	62.98
VUM KP.3	2	0.76
VUM KP.3.1.1	10	3.82
VUM LP.8.1	41	15.65
VUM NB.1.8.1	1	0.38
VUM XEC	39	14.89
Total	262	100.00

Fuente: INCIENSA, informes interactivos de variantes genómicas, corte 23 de junio 2025.

Sarampión

José Aaron Agüero Zumbado
Unidad de Epidemiología.
Dirección de Vigilancia de la Salud

Situación Epidemiológica Mundial

Los datos mensuales de vigilancia de sarampión y rubéola, publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2025, hasta el 10 de abril del 2025, informan que se notificaron 82068 casos sospechosos de sarampión, en 156 Estados Miembros de las seis regiones de la OMS, de los cuales 39281 (47,9%) fueron confirmados. En el año 2024, se informaron 706913 casos sospechosos de sarampión en 184 Estados Miembros de la OMS, de los cuales 359466 (50,9%) fueron confirmados.

Situación en la Región de las Américas

En 2025, entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 22, en la Región de las Américas, 6111 casos de sarampión han sido confirmados, incluyendo cuatro defunciones, en Argentina (n= 33), Belice (n= 7) 2, el Estado Plurinacional de Bolivia (n= 1), Brasil (n= 5), Canadá (n= 2968), México (n= 1926 casos, incluyendo una defunción) y los Estados Unidos de América (n= 1166, incluyendo tres defunciones). Este total representa un aumento de 11 veces en comparación con los 205 casos de sarampión notificados en el mismo periodo del 2024. Sin embargo, al 20 de junio en la SE 24, el Boletín de Sarampión, de OPS-OMS reporta 7150 casos en las Américas. Perú (n=3), Brasil (n=5), Argentina (n=34), Bolivia (n=43), Costa Rica (n=1), México (n=2434), USA (n=1210), Canadá (n=3391).

En las Américas de la SE 22 a la SE 24, se determina un aumento de 1039 casos de sarampión en dos semanas, se atribuye el aumento de los casos a los países de México (reporta 508 casos nuevos de sarampión, con al 49% del total de casos), Canadá (423 casos nuevos, representa un 40,7% del total de casos).

Situación Epidemiológica en Costa Rica

En Costa Rica, el año 2025, se han notificado 35 casos sospechosos de sarampión descartándose por laboratorio y confirmándose un caso importado de sarampión por laboratorio el 15 de mayo en la provincia de Guanacaste.

En Costa Rica el último caso endémico de sarampión se detectó en 1999, y de Rubéola en el 2001. Los equipos de vigilancia interinstitucionales han detectado posteriormente, en el año 2019 un total de 10 casos de sarampión, 3 casos importados (en personas extranjeras,), y 7 asociados a la importación (caso confirmado por laboratorio, adquirida localmente y que forma parte de una cadena de transmisión originada por un caso importado). En el año 2023 se detectó 1 caso de fuente desconocida, confirmado por vigilancia en el laboratorio, posterior a investigaciones no se encontraron casos secundarios. En el año 2024, se descartaron por laboratorio 86 casos sospechosos de sarampión, no se confirmaron casos.

El Sarampión es una enfermedad causada por un virus, es muy contagiosa afecta principalmente a niños, y se transmite por pequeñas gotitas de la nariz, boca y faringe, al hablar, toser o estornudar. El enfermo inicia con malestar general, secreción nasal, tos, conjuntivitis y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas (manchas de Koplik), posteriormente, desarrolla fiebre alta, un brote de “manchas y pelotitas en piel” rojizo (exantema maculo-papular), generalmente inicia en la cara y cuello, luego pasa al tórax, abdomen y espalda, finalmente en brazos y piernas.

Los grupos que presentan mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad son las poblaciones no vacunadas o con esquemas incompletos, por eso la importancia de mantener coberturas óptimas de vacunación. El sarampión es muy contagioso tiene capacidad de infectar a 18 personas por cada persona enferma.

El diagnóstico del sarampión se confirma por exámenes de laboratorio, en Costa Rica el Centro Nacional de Referencia Virológica del Inciensa es el laboratorio nacional que confirma los casos de sarampión.

El tratamiento para el sarampión es individualizado y conservador según el médico tratante, sin embargo, pueden presentar complicaciones. Todo caso se vigila diariamente, y si desarrolla complicaciones se debe trasladar a un hospital.

En Costa Rica, las **coberturas de vacunación** contra Sarampión, Rubéola y Paperas (SRP) han mejorado las coberturas alcanzadas con la primera dosis (superiores al 95%) y con segundas dosis (con coberturas por debajo del 90%).

Es importante señalar que, en el país, cada 5 años se hace campañas de vacunación contra SRP, para el grupo de susceptibles (personas sin vacuna). La última campaña de vacunación en el país fue en el año 2024, se alcanzó una cobertura de vacunación del 90.7%, y al realizar el Monitoreo Rápido de Vacunación, a través de actividades de verificación en el campo, se alcanzó una cobertura del 95% que es sinónimo de protección.

Para prevenir las enfermedades lo principal es la vacunación, el esquema actual aplica la vacuna a los 15 meses y a los 4 años. Es importante aclarar que dos dosis de vacuna de SRP previenen la enfermedad hasta en un 97%, y una sola dosis, previene hasta en un 93% la enfermedad. La única manera de prevención es contar con el esquema completo de vacunación contra SRP, por lo que recomendamos a nuestra población completar el esquema de vacunación, y muy importante, también antes de viajar a los sitios donde actualmente se reportan brotes.

Recomendaciones para la población

-Revisar esquemas de vacunación sarampión, y completarlos, principalmente en niños (contar como mínimo con 2 dosis de vacuna).

-Si inicia con un brote o erupción maculo papular, asistir al establecimiento de salud correspondiente, debe informar si estuvo en contacto con extranjeros enfermos o si viajó a países con casos de sarampión.

- Si se enferma en Costa Rica y le diagnostican por laboratorio la enfermedad de sarampión, debe continuar aislamiento y los profesionales en salud realizarán un seguimiento respectivo.

Los países con más casos de sarampión son México, Canadá, USA, Bolivia y Argentina.

-Si realizan viajes a países donde existen brotes de sarampión, se recomienda tanto en niños como adultos contar como mínimo con dos dosis de vacuna. Además, como recomendación, se pueden aplicar una vacuna de refuerzo como medida de protección.

-En países donde existe casos de sarampión, se recomienda usar mascarilla, medidas de higiene como el protocolo del lavado de manos, entre otros.

-Si viajó a países con brotes de sarampión-rubéola y presenta síntomas de estas enfermedades favor acudir al establecimiento de salud más cercano.

Recomendaciones al sector salud

- Mantener altas coberturas de vacunación iguales o mayores de 95%, con dos dosis de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de enfermedad febril eruptiva, es decir, de personas con fiebre y erupción en piel o sarpullido, que permiten la identificación temprana de casos.
- Los equipos de vigilancia deben responder de forma rápida a casos confirmados por laboratorio a través de la vigilancia, mediante barridos de vacunación y búsqueda activa de otros casos. Seguir lo indicado en el Protocolo Nacional de Vigilancia 2025.

Protocolo para la vigilancia epidemiológica del Sarampión

Debido a la alerta sanitaria de casos de sarampión, el Ministerio de Salud hace de conocimiento, la actualización del Protocolo para la Vigilancia del Sarampión y Rubéola, elaborado por el Equipo Técnico Nacional (Ministerio de Salud, CCSS, Inciensa) y colaboradores expertos de Costa Rica y de OPS-OMS. El protocolo se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Salud, en el siguiente enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/vigilancia-de-la-salud/normas-protocolos-guias-y-lineamientos/protocolos-vigilancia-de-la-salud/8802-protocolo-para-la-vigilancia-epidemiologica-del-sarampion-rubeola-2025/file

El objetivo general del protocolo es establecer el proceso para el abordaje epidemiológico de casos sospechosos y confirmados de sarampión y rubéola, que orienten a los trabajadores de establecimientos de servicios de salud públicos y privados. Entre los objetivos específicos se indica, establecer las acciones de vigilancia epidemiológica, en la detección, notificación, aislamiento, recolección de muestras para el diagnóstico, investigación y seguimiento de un caso sospechoso; así como implementar las búsquedas activas comunitarias e institucionales.

Caso de sarampión en mayo del 2025

El 13 de mayo se detecta y notifica un caso sospechoso de sarampión en Guanacaste, y se confirma por laboratorio el 15 de mayo en el Centro Nacional de Referencia Virológica del Inciensa. El caso corresponde a una mujer extranjera, de 18 años, sin antecedentes vacunales, tres contactos directos integran el núcleo familiar, en muy buen estado general, el caso se aisló y posteriormente, sin riesgo de transmisión, bajo consideraciones clínico, epidemiológicas se trasladó a su país de residencia. No se han encontrado casos secundarios en él país. El Ministerio de Salud trabajó interinstitucionalmente con la CCSS, Inciensa, Hospital Privado, realizando búsquedas activas de casos secundarios en los sitios visitados por el caso, y generó las acciones respectivas para la contención del brote salvaguardando la salud de la población costarricense. No se registraron casos secundarios.

El Ministerio de Salud reconoce el esfuerzo y la capacidad de respuesta de los equipos interinstitucionales realizada por la Región Chorotega en Guanacaste de los niveles regional y local al detectar el caso, realizar las acciones epidemiológicas, medidas de contención del brote, búsquedas de posibles casos secundarios, además de realizar BAC en los lugares de desplazamiento. El trabajo realizado es una excelente labor por parte del sector salud y se felicita a todos aquellos funcionarios que participaron en las diferentes actividades (CCSS, Ministerio de Salud, Centro Nacional de Referencia de Virología en Inciensa y Hospital Privado) en los tres niveles de gestión.

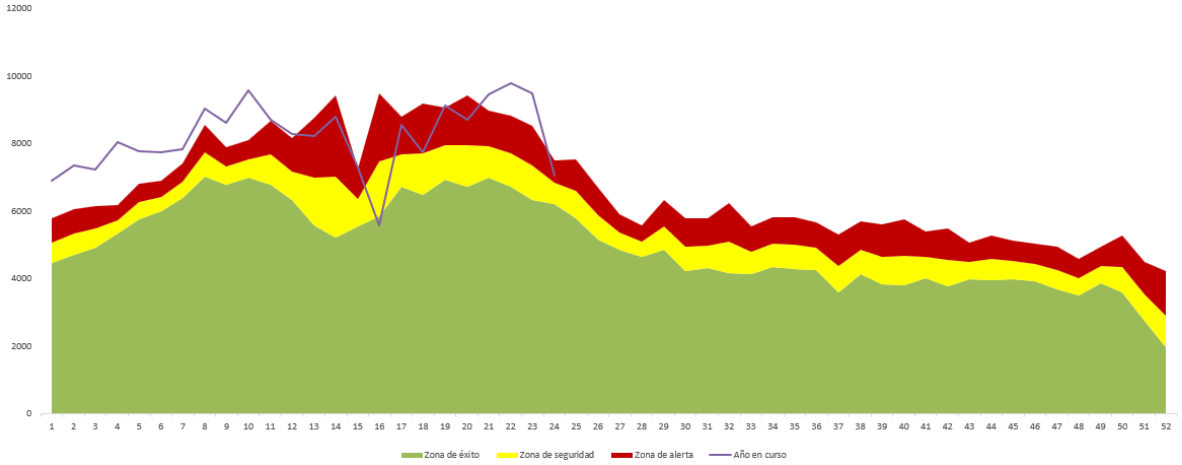
Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 23 de junio 2025.

Ivannia Caravaca Rodríguez.
Unidad de Epidemiología.
Dirección de Vigilancia de la Salud

En la semana epidemiológica 24 del 2025 se presentan 197139 casos acumulados de EDA. Según el comportamiento epidemiológico de este evento, se denota una curva epidémica en zona de alerta, con una tasa de 3681 casos de diarrea por cada 100 000 habitantes.

La incidencia de las EDA para la Semana Epidemiológica (SE) 24 refleja una disminución de casos notificados en relación con el 2023, año referente por el registro del aumento de casos y tasas por 100 000 habitantes en todo el territorio nacional. Para la SE 23 se continúa observando una predisposición disminuida en la frecuencia de casos, observándose una tendencia a la baja comparado con los años anteriores, es evidente que los fenómenos climáticos del niño y la niña afectan la cantidad de casos de diarrea, este año con el fenómeno de la niña se muestra a la fecha el canal endémico en zona de alerta situación semejante en el año 2023 donde se atravesó el mismo fenómeno. Se destaca que los datos son preliminares, y actualmente se encuentran los datos en revisión, por lo que puede presentarse afectación en el canal endémico.

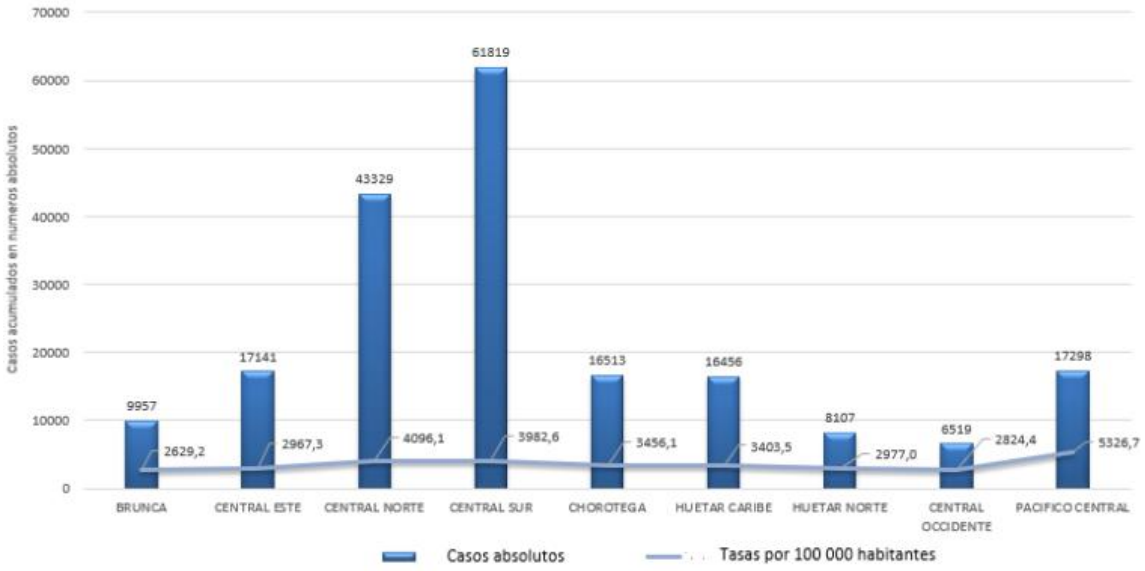
Gráfico 1
Costa Rica. Canal endémico para EDA por semana epidemiológica hasta la SE 24. Años 2017- 2025. (Se excluyen del 2020 al 2022 por pandemia COVID-19)



Fuente: Datos preliminares, Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Los 10 cantones con mayores tasas de incidencia de EDA a la SE 24 son: Santa Cruz, Montes de Oro, Vázquez de Coronado, Orotina, Puntarenas, Flores, Garabito, San Rafael, Matina, Goicochea, Alajuela, Parrita, donde predominan las tasas más altas. Las Regiones Rectoras con más casos son: Pacifico Central, Central Norte, Central Sur. El grupo de edad más afectado es el de adultos de 20 a 39 años.

Gráfico 2
Costa Rica. Incidencia de casos de EDA, según región del Ministerio de Salud. SE 24, 2025.



Fuente: Datos preliminares. Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Se recomienda retomar las campañas de educación a la población del Protocolo de Lavado de Manos, las adecuadas prácticas de higiene personal y de cocción y manipulación de alimentos.
El sistema de salud reporta una alta frecuencia de casos de diarreas, ya sean virales o bacterianas, superiores al comportamiento usual, el Protocolo de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos dirige el proceso de la investigación adecuada de los casos, así como los flujogramas de trabajo ante diferentes posibles causas, es importante retomar las actividades de vigilancia e investigación ante las alertas.

Meningitis

Franchina Murillo Picado
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Paola Pérez Espinoza
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

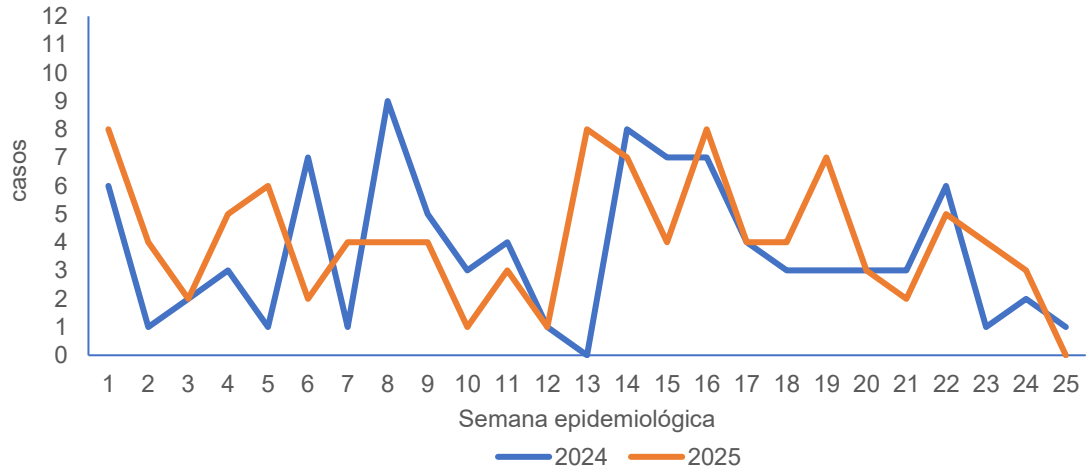
La meningitis es una peligrosa inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, causada principalmente por una infección bacteriana o vírica.

La meningitis causada por una infección bacteriana suele ser la más grave que provoca unas 250,000 muertes por año y posibles epidemias de rápida propagación. Ocasiona la muerte de una de cada diez personas infectadas, en su mayoría niños y jóvenes y deja a una de cada cinco con discapacidades duraderas, como convulsiones, pérdida de audición y visión, daños neurológicos y deterioro cognitivo.

En Costa Rica, a la semana epidemiológica 24 del año 2025, se han reportado 103 casos por boleta VE01 por sospecha de meningitis con una tasa de incidencia de 1,9 por 100,000 habitantes. En el año 2024 se reportaron 91 casos de meningitis acumulado respecto a la misma semana con un aumento de 10,9%. No se registran brotes.

De las 9 Regiones del Ministerio de Salud, la región Central Este notificó el 29,7,6% de los casos (30/103), seguido de la Central Sur con el 23,8% (24/103) y Central Norte con el 19,8% (20/103).

Figura 1.
Costa Rica: Casos sospechosos de meningitis comparativa año 2024 con el 2025 a la semana epidemiológica 24, 2025



Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

En la siguiente tabla se enlista los cantones con las tasas más altas de meningitis. Dota de la provincia de San José es el que tiene la tasa más alta de 12,2 seguido están Cartago con 10,1 y Osa de la provincia de Puntarenas con 9,5.

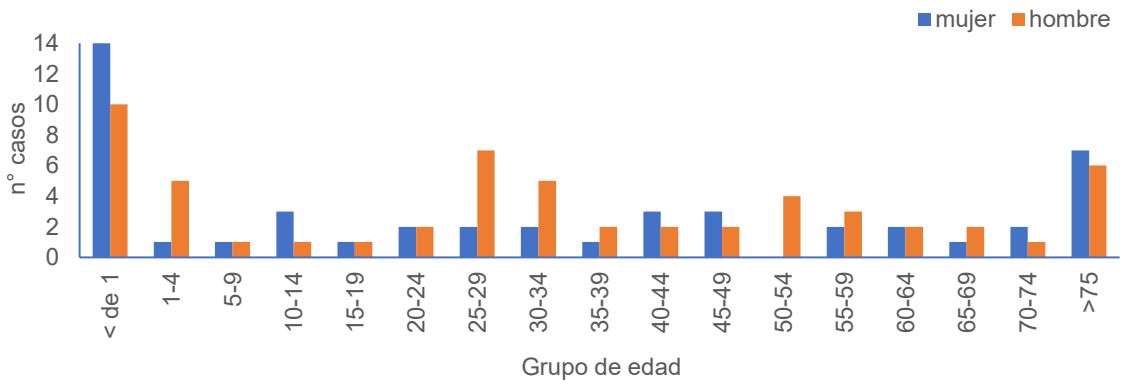
Figura 2.
Costa Rica: Casos notificados de meningitis según cantón, acumulado a la semana epidemiológica 24, 2025 (tasa p/100.000 habitantes)

cantón	casos	tasa
Dota	1	12,2
Cartago	17	10,1
Osa	3	9,5
Cañas	3	8,7
Leon Cortes	1	7,0
Santa Cruz	5	6,7
Alvarado	1	6,3
Jimenez	1	6,1
Sarapiqui	5	5,3
Tarrazu	1	5,2
Santa Barbara	2	4,4
Valverde Vega	1	4,3
Flores	1	3,8
Perez Zeledon	5	3,5
La Union	4	3,4
Moravia	2	3,1
Aserri	2	3,0
Goicoechea	4	2,8
Quepos	1	2,8
Turrialba	2	2,7
Esparza	1	2,5
Liberia	2	2,4
Alajuela	7	2,1
El Guarco	1	2,1
Talamanca	1	2,1
San Jose	7	2,0
Desamparados	5	2,0
Alajuelita	2	2,0
Naranjo	1	2,0
Barva	1	2,0
Santo Domingo	1	2,0
San Rafael	1	1,7
Guacimo	1	1,7
Montes de Oca	1	1,6
Paraiso	1	1,5
Siquirres	1	1,5
Escazu	1	1,4
Heredia	2	1,3
Pococi	2	1,2
Grecia	1	1,0
San Carlos	1	0,5
Total	103	1,9

Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

La figura 3, indica la distribución de los casos sospechosos según sexo y grupo de edad. El 45,6% de los casos (47/103) son mujeres y el 54,3% (56/103) son hombres. El 23,3% de los casos (24/103) son menores de 1 año.

Figura 3.
Costa Rica: Casos sospechosos por meningitis según sexo y edad, a la semana epidemiológica 24, 2025



Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

Infecciones de transmisión sexual

Pamela Domínguez Saavedra
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Stephany Alvarado Garita
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

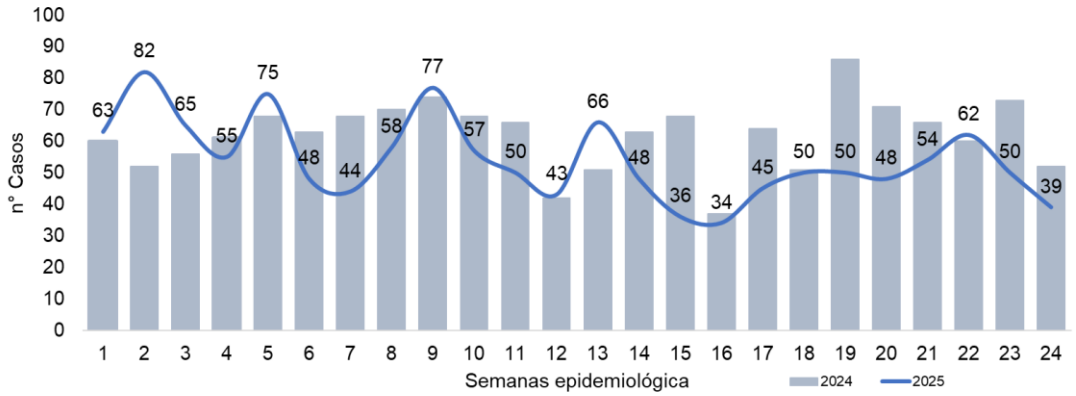
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), son de reporte obligatorio según el Reglamento de Vigilancia de la Salud 40556-S. Por consiguiente, la vigilancia es relevante para la salud pública del país. Para las primeras 24 semanas del año 2025, se han reportado las siguientes ITS: sífilis en todas sus formas, gonorrea, herpes virus y virus del papiloma humano.

Sífilis en todas sus formas

Es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria *Treponema pallidum*, la cual es totalmente prevenible y tratable. Esta infección se trasmite por relaciones sexuales sin protección y de la madre al bebé durante el embarazo. Por ende, esta infección afecta a la morbilidad y mortalidad del país.

Para las primeras 24 semanas del 2025, se han notificado 1299 casos con una tasa 24,26 por 100 000 habitantes, en el mismo periodo del año 2024 se reportaron 1490 casos, lo que representa para el año 2025 un descenso del 12,81% con 191 casos menos. En el gráfico 1, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 1.
Costa Rica: Casos confirmados por sífilis en todas sus formas, según fecha de inicio de síntomas en el reporte semanal, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento epidemiológico de esta enfermedad en las primeras 24 semanas del año, se reportaron en los hombres un 55,97% de los casos (727/1299), con una tasa de 26,99 por 100 000 habitantes, las mujeres presentan el 44,00% de los casos (572/1299), con una tasa de 21,49 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporto son: 20 a 64 años con 80,29% (1043/1299), seguidos por el de mayores de 65 años con 10.00% con (129/1299), luego por el grupo de 15 a 19 años con 4,60% con (60/1299), y los menores de 1 año con el 4,90% de los casos (64/1299), los menores de 10 a 14 años un caso, grupo de 1 a 4 años dos casos y el grupo de 5 a 9 años sin casos, ver cuadro 1.

Cuadro 1.
Costa Rica: Casos de sífilis en todas sus formas, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 24 del 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	64	94,7
de 1 a 4 años	2	0,7
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	1	0,3
de 15 a 19 años	60	15,8
de 20 a 24 años	159	40,9
de 25 a 29 años	203	47,7
de 30 a 34 años	200	45,0
de 35 a 39 años	137	30,3
de 40 a 44 años	111	27,2
de 45 a 49 años	87	25,1
de 50 a 54 años	51	17,4
de 55 a 59 años	45	16,1
de 60 a 64 años	50	19,1
de 65 a 69 años	41	19,2
de 70 a 74 años	35	22,5
75 años y más	53	25,1
Total	1299	24,26

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el siguiente cuadro, se presenta el comportamiento de esta enfermedad, según provincias.

Cuadro 2.
Costa Rica: Casos notificados de sífilis en todas sus formas según provincias de procedencia. Números absolutos y tasas (Tasa p/100.000 habitantes), semana 24 del 2025

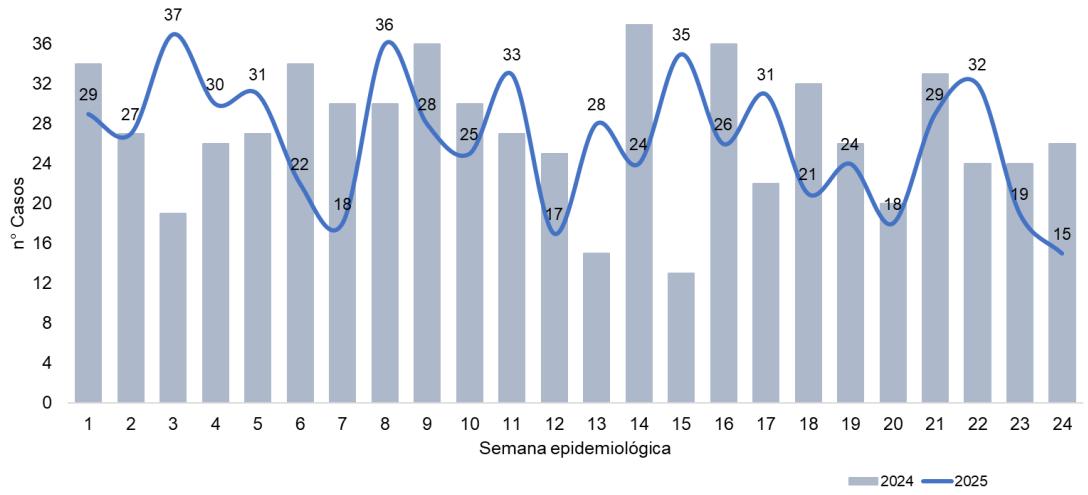
Provincias	Nº	Tasa
San José	450	26,2
Alajuela	191	17,5
Cartago	169	30,4
Heredia	93	16,6
Guanacaste	74	17,6
Puntarenas	102	19,3
Limón	220	45,5
Total	1299	24,26

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Gonorrea

Es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*, la cual es prevenible y tratable. Esta enfermedad se trasmite por relaciones sexuales sin protección y de la madre al bebé durante el parto. Por consiguiente, esta infección afecta a la salud pública del país. En las primeras 24 semanas del 2025, se han notificado 635 casos con una tasa de 11,9 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 655 casos, lo que representa para el año 2025 un descenso del 3,00 % con 20 casos menos. En el gráfico 2, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento de esta enfermedad en las primeras 24 semanas del año en curso reporta en los hombres un 83,31% (529/635), con una tasa de 19,60 por 100 000 habitantes. En las mujeres se ha reportado el 16,70% (106/635), con una tasa de 4,00 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporte son: 20 a 64 años con 82,52% (524/635), seguidos por el grupo de 15 a 19 año con 14,33% (91/635), y los mayores de 65 años con 2,36% (15/635), los menores de 1 año un caso y los de 1 a 14 años con cuatro casos, ver cuadro 3.

Cuadro 3
Costa Rica: Casos de gonorrea por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 24 del 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
Menos 1 año	1	1,5
1 a 4	1	0,4
5 a 9	1	0,3
10 a 14	2	0,5
15 a 19	91	24,0
20 a 24	156	40,1
25 a 29	122	28,7
30 a 34	89	20,0
35 a 39	68	15,0
40 a 44	34	8,3
45 a 49	14	4,0
50 a 54	20	6,8
55 a 59	14	5,0
60 a 64	7	2,7
65 a 69	9	4,2
70 a 74	3	1,9
Más 75 años	3	1,4
Total	635	11,90

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 4, se presentan el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 4
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según provincia.
Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 24 del 2025

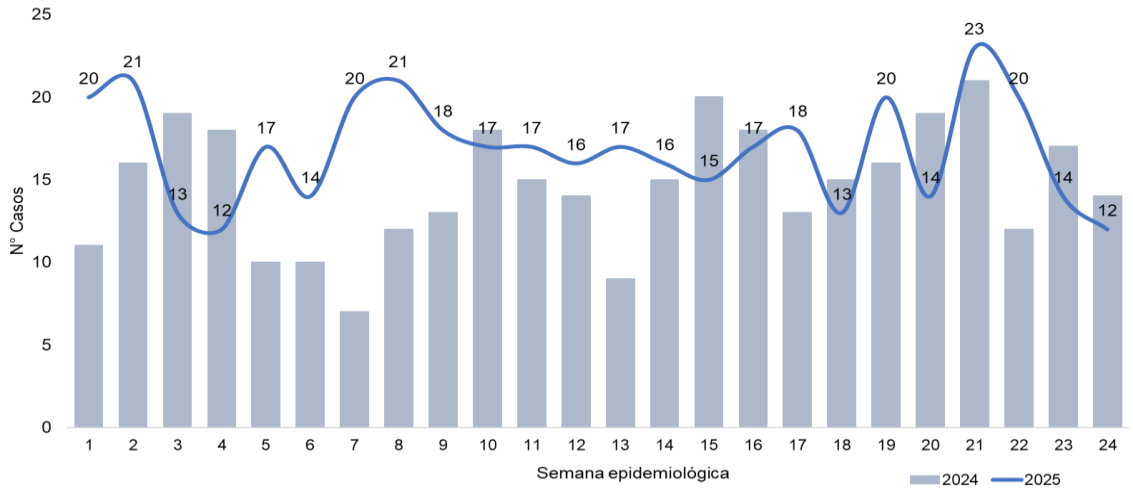
Provincias	Casos	Tasa
San José	245	14,3
Alajuela	97	8,9
Cartago	55	9,9
Heredia	60	10,7
Guanacaste	20	4,8
Puntarenas	69	13,1
Limón	89	18,4
Total	635	11,90

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus Herpes

El virus del herpes es otra de las Infección de transmisión sexual, que se ha reportado en las primeras 24 semanas del año en curso, con 405 casos con una tasa de 7,60 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 352 casos, lo que representa para el año 2025 un incremento del 15,00%, con 53 casos más que el periodo anterior. En el gráfico 3, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 3.
Costa Rica: Casos notificados por el virus del herpes, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

El comportamiento del virus del herpes en las primeras 24 semanas del año se ha notificado en mujeres un 67,41% de los casos (273/405), con una tasa de 10,3 por 100 000 habitantes, en hombres se reportó el 32,59% de los casos con (132/405), con una tasa de 4,9 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad y los que reportan más son: 20 a 64 años con 81,73% (331/405), seguidos por 15 a 19 años con 13,09% (53/405), mayores de 65 años con 4,20% con (17/405), los menores de 1 año reportan un caso y el de 10 a 14 años con tres casos, los otros grupos no reportan casos, ver cuadro 5.

Cuadro 5.
Costa Rica: Casos de virus del herpes, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 24 del 2025

Grupos de edad	Caso	Tasa
Menos 1 año	1	1,5
1 a 4	0	0,0
5 a 9	0	0,0
10 a 14	3	0,8
15 a 19	53	14,0
20 a 24	77	19,4
25 a 29	58	13,5
30 a 34	56	12,5
35 a 39	50	11,1
40 a 44	29	7,4
45 a 49	22	6,6
50 a 54	10	3,4
55 a 59	15	5,4
60 a 64	14	5,4
65 a 69	11	5,4
70 a 74	4	2,7
Más 75 años	2	1,0
Total	405	7,60

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 6, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 6
Costa Rica: Casos notificados por virus del herpes, según provincias. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 24 del 2025

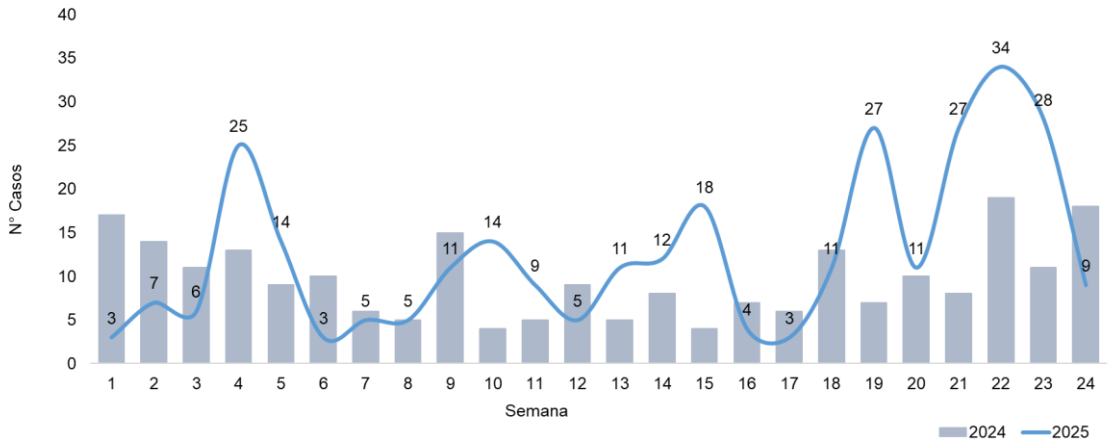
Provincias	Casos	Tasa
San José	194	11,4
Alajuela	38	3,5
Cartago	28	5,1
Heredia	29	5,2
Guanacaste	10	2,4
Puntarenas	51	9,8
Limón	55	11,5
Total	405	7,60

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus del Papiloma Humano (VPH)

Es una de Infección que se trasmite por por contacto de la piel o por relaciones sexuales sin protección, se puede prevenir con el uso de condones y no tener relaciones sexuales cuando la pareja tiene síntomas. En las primeras 24 semanas del 2025, se notificaron 302 casos con una tasas de 5,60 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 234 casos, lo que representa para el año 2025 un incremento del 29,00%, con 68 casos más que el periodo anterior ver gráfico 4.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados por Virus del Papiloma Humano, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento del VPH en las primeras 24 semanas del año, según sexo se notificaron en las mujeres un 92,72% (280/302), con una tasa de 10,50 por 100 000 habitantes, en los hombres se reportó el 7,28% (22/302), con una tasa de 0,80 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporte son: 20 a 64 años con 97,70% (295/302), seguidos por 15 a 19 años con 2,00% (6/302), los mayores 65 años un caso y los otros grupos no reportan casos, ver cuadro 7.

Cuadro 7.
Costa Rica: Casos notificados por Virus del Papiloma Humanos, por grupos de edad. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 24 del 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	0	0,0
de 1 a 4 años	0	0,0
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	0	0,0
de 15 a 19 años	6	1,6
de 20 a 24 años	17	4,4
de 25 a 29 años	17	4,0
de 30 a 34 años	53	11,9
de 35 a 39 años	62	13,7
de 40 a 44 años	42	10,3
de 45 a 49 años	32	9,2
de 50 a 54 años	20	6,8
de 55 a 59 años	31	11,1
de 60 a 64 años	21	8,0
de 65 a 69 años	1	0,5
de 70 a 74 años	0	0,0
75 años y más	0	0,0
Total	302	5,60

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 8, se presentan el comportamiento de esta enfermedad, según las siete provincias del país.

Cuadro 8.
Costa Rica: Casos notificados por Virus del Papiloma Humano, según provincia. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 24 del 2025

Provincias	Nº	Tasa
San José	48	2,8
Alajuela	24	2,2
Cartago	8	1,4
Heredia	7	1,3
Guanacaste	91	21,7
Puntarenas	120	22,8
Limón	4	0,8
Total	302	5,60

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Miasis por gusano barrenador en humanos

María José Lafuente González
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

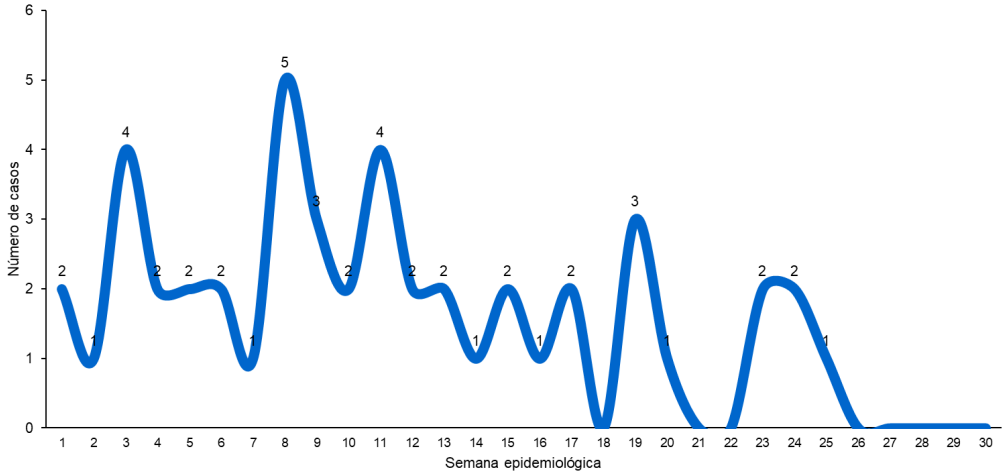
Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos de miasis por gusano barrenador en humanos para la semana epidemiológica (SE) 25 del año 2025, según establece el Reglamento de Vigilancia de la Salud Decreto N°40556-S y el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos es un evento de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de esta miasis, por medio de la boleta VE-01, para el año 2025 a la SE 25, se tienen los siguientes datos:

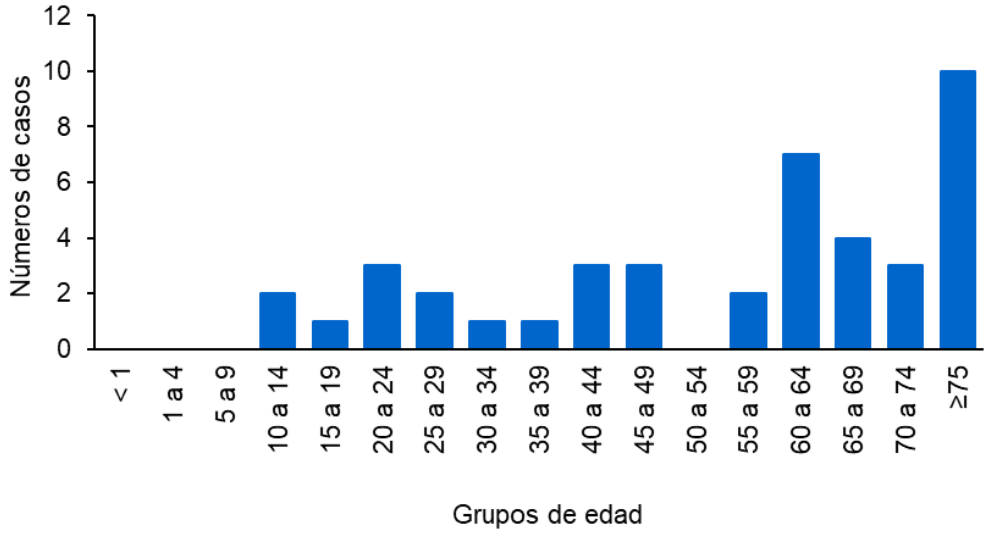
- Casos acumulados de miasis por gusano barrenado en humanos suman un total de 47 casos
- Casos por grupos de edad quinquenal tienen un predominio en las personas de 20 a 64 años (22/47) y las adultas de 65 y más años con más casos reportados (22/47)

Gráfico 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador según SE de la 01 a la 25, 2025



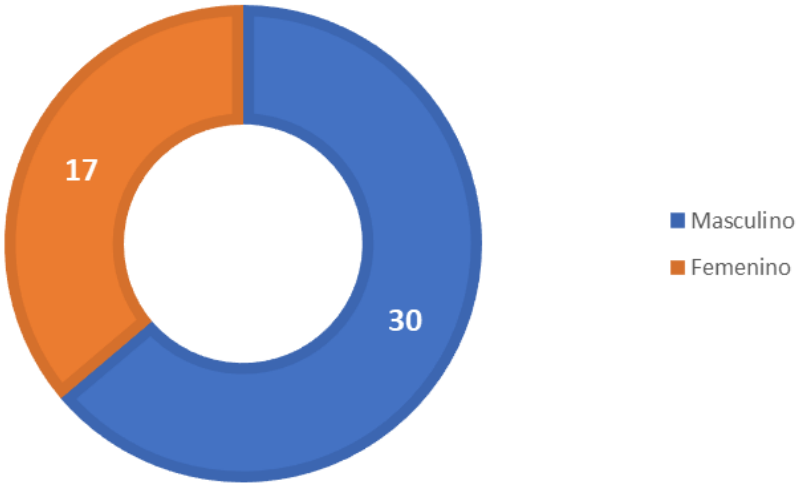
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador según grupos de edad quinquenal, de la SE 01 a la 25, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador según sexo, de la SE de la 01 a la 25, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos, en el año 2025, presenta un predominio en los hombres con 30 casos notificados con una tasa de 1,1 por 100.000 habitantes y en las mujeres con 17 casos notificados con una tasa de 0,6 por 100.000 habitantes.

Cuadro 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasas (tasa p/100.000 habitantes) según provincia de procedencia, de la SE 01 a 25, 2025

Provincias	Casos	Tasas
Total	**47**	**0,9**
San José	8	0,5
Alajuela	11	1,0
Cartago	3	0,5
Heredia	5	0,9
Guanacaste	7	1,7
Puntarenas	7	1,3
Limón	6	1,2

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el cuadro 1, se presenta el comportamiento de esta enfermedad por provincia de procedencia, por casos y tasas por 100.000 habitantes notificados a la SE 25, presentando mayor número de casos la provincia de Alajuela (11/47) seguido por la provincia de San José (8/47), Guanacaste (7/47) y Puntarenas (7/47).

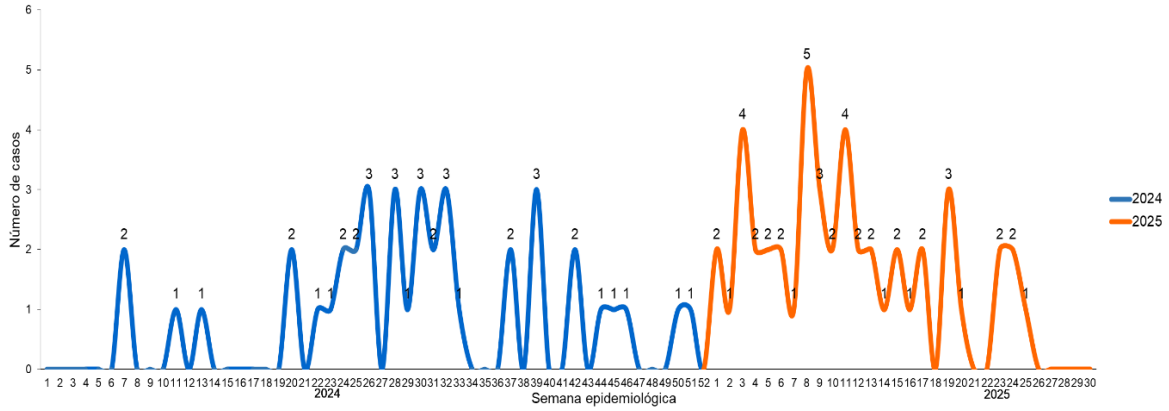
Cuadro 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasas (tasa p/100.000 habitantes) según región del Ministerio de Salud de procedencia, de la SE 01 a 20, 2025

Regiones	Casos	Tasas
Total	**47**	**0,9**
Central Norte	9	0,9
Chorotega	7	1,5
Central Sur	7	0,5
Brunca	6	1,6
Huetar Caribe	6	1,2
Central Occidente	5	2,2
Pacifico Central	3	0,9
Central Este	3	0,5
Huetar Norte	1	0,4

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el cuadro 2, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las nueve regiones del Ministerio de Salud, siendo la región Central Norte (9/47) la que presenta el mayor número de casos.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, según SE, año 2024 al corte de la SE 25 del 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024 y 2025

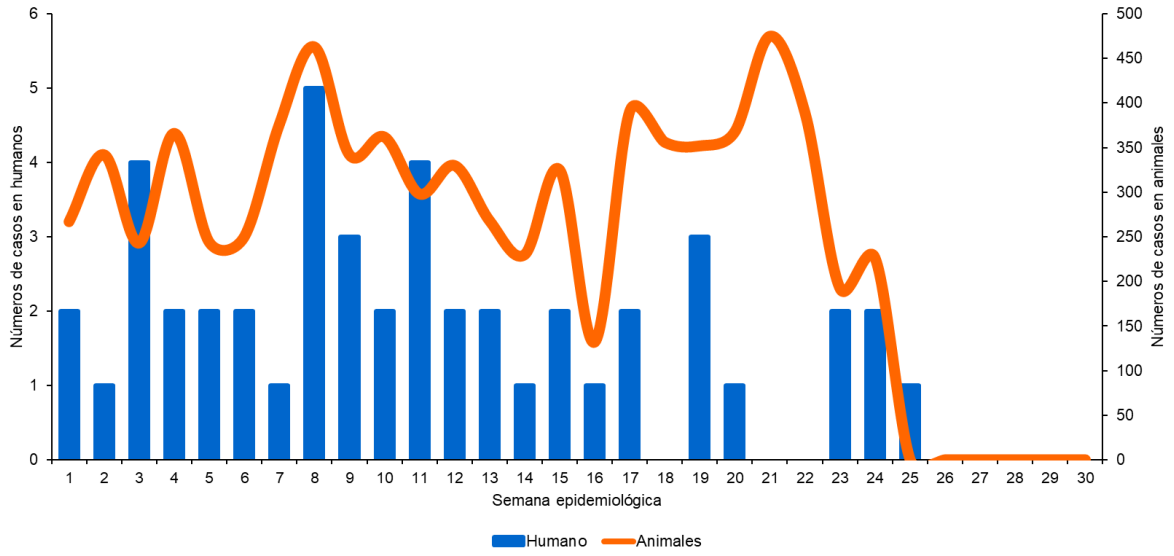
Cuadro 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador a la SE 25 del 2024 y 2025

SE	Número de casos	
	2024	2025
1	0	2
2	0	1
3	0	4
4	0	2
5	0	2
6	0	2
7	2	1
8	0	5
9	0	3
10	0	2
11	1	4
12	0	2
13	1	2
14	0	1
15	0	2
16	0	1
17	0	2
18	0	0
19	0	3
20	2	1
21	0	0
22	1	0
23	1	2
24	2	2
25	2	1
Total	**12**	**47**

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024 y 2025

En el gráfico 4 se puede observar el comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos por SE 01 a 52 del 2024 y SE 01 a 25 del 2025 y en el cuadro 3 el comportamiento de los casos de la SE 01 a 25 del 2024 y SE 01 a 25 del 2025, observando un aumento significativo de los casos durante la SE 08 del 2025, con un total de 47 casos confirmados por esta enfermedad, siendo que para la SE 25 del 2024 se confirmaron 12 casos de miasis por gusano barrenador en el país.

Gráfico 5
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador en humanos y animales según SE de la 01 a la 25, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Boletín Epidemiológico Extraordinario Gusano Barrenador actualizado al 31 de mayo del 2025, SENASA / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el gráfico 5, se muestran los casos de miasis por gusano barrenador en humanos y animales por SE de la 01 a la 25 del 2025, con 47 casos confirmados en humanos y 7587 casos confirmados en animales.

Dado que la mosca continúa circulando en el territorio nacional y existe la declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación de la enfermedad de Gusano Barrenador, Decreto Ejecutivo N° 44382–MAG (*Cochliomyia hominivorax*), es de suma importancia que ante la identificación de un caso sospechoso en humanos se realice el abordaje bajo el enfoque de **Una Sola Salud**, mediante coordinación interinstitucional Ministerio de Salud-Servicio

Nacional de Salud Animal-Ministerio de Ambiente y Energía según corresponda, para identificar casos sospechosos en humanos y/o animales que puedan ser atendidos de manera oportuna.
A continuación, se brinda algunas generalidades de prevención y control de esta enfermedad:

- Mantener higiene personal, lavarse las manos regularmente con agua y jabón
- Control, tratamiento e higiene en lesiones en piel de acuerdo con la recomendación del médico tratante
- Asistir al establecimiento de salud público o privado cuando presente síntomas asociados a la enfermedad, tales como: dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia, se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la lesión herida
- Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, realizando revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas e informar a las autoridades de salud animal (SENASA) sobre la aparición de animales con gusaneras para que reciban atención oportuna.

Casos notificados de violencia intrafamiliar

Gloriela Brenes Murillo
Unidad de Epidemiología
Dirección Vigilancia de la Salud

Kricia Castillo Araya
Unidad Seguimiento de Indicadores en Salud
Dirección Vigilancia de la Salud

2025

Introducción

-Violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres es una manifestación de desigualdades estructurales prevenirla y erradicarla requiere transformaciones profundas en los sistemas sociales, políticos y económicos.

Se manifiesta en diversos contextos, entre ellos:

-Contexto social:
-Contexto político
-Contexto económico
-Violencia Intrafamiliar

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia intrafamiliar se enmarca dentro de una definición más amplia de violencia. La OMS define la violencia como:

"El uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones".

En el contexto específico de la violencia intrafamiliar, la OPS-OMS la describe como:

"La agresión física, psicológica o sexual cometida por el esposo o conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes civiles u otros familiares".

Este tipo de violencia puede manifestarse de muchas formas, incluyendo:
- Violencia física: golpes, empujones, quemaduras, etc.
- Violencia psicológica: humillaciones, amenazas, aislamiento, control excesivo.
- Violencia sexual: cualquier acto sexual forzado o no consentido dentro del entorno familiar.
- Violencia económica: control del dinero, prohibición de trabajar o estudiar.

La violencia de género y contra las mujeres es un grave problema de salud pública, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) generando:

1.Alta incidencia:
Más de un tercio de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja.

2.Consecuencias para la salud:
-Lesiones físicas graves o muerte.
-Trastornos de salud mental como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático.
-Problemas de salud sexual y reproductiva: infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos inseguros.
-Abuso de sustancias como alcohol o drogas.

3. Impacto en los sistemas de salud:
-Aumenta la demanda de servicios médicos, psicológicos y sociales.
-Requiere formación del personal de salud para detectar y atender adecuadamente a las víctimas.
-Necesita coordinación intersectorial para una respuesta integral.

4.Violación de derechos humanos:
Además de ser un problema de salud, la violencia contra las mujeres representa una grave violación de sus derechos fundamentales.

-Importancia de la notificación de casos atendidos de violencia intrafamiliar

Es por ello por lo que, notificar los casos de violencia intrafamiliar es crucial para proteger a las víctimas, prevenir futuras agresiones y fortalecer la respuesta institucional ya que permite activar mecanismos de protección como medidas cautelares, atención médica urgente, romper el ciclo de violencia y evitar consecuencias más graves, como femicidios.

Por otro lado, coadyuva en el acceso a justicia y reparación, fortaleciendo el principio de no impunidad, además de permitir una atención integral en términos de acceso a servicios de salud, apoyo psicológico, asesoría legal entre otros.

Así mismo permite una intervención temprana y coordinada entre instituciones de manera que se previenen nuevos casos, las denuncias visibilizan el problema y permiten identificar patrones de riesgo y sobre todo ayudan a diseñar políticas públicas más efectivas y focalizadas.
Finalmente, la generación de datos a través de las notificaciones alimenta los sistemas de información institucional permitiendo monitorear la magnitud del problema y evaluar la efectividad de las intervenciones.
En Costa Rica la notificación obligatoria de los casos de VIF atendidos se realiza según el Decreto de Vigilancia de la Salud 40556-S.
Con base en los anterior a continuación se brindará la información de datos acumulados de los casos notificados a través de la *Boleta de Notificación Individual Obligatoria (VE01*), en la semana epidemiológica (SE) N°24, (8 al 14 de junio de 2025).

Acumulado de casos notificados de violencia intrafamiliar según variables

Sexo

Con base en la información revisada de los casos de violencia intrafamiliar notificados en la SE 24-2025 las mujeres representan el sector de la población con más casos, es decir son las más afectadas por la violencia intrafamiliar y en todas sus formas, tal y como se evidencia en la tabla 1.

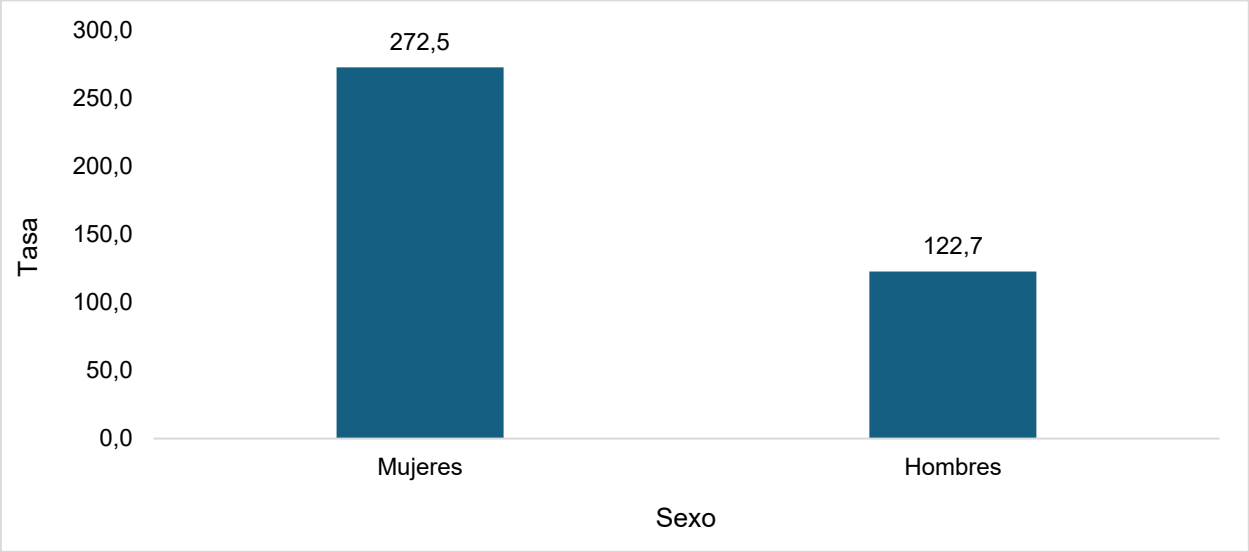
Tabla 1.
Costa Rica: Totales de casos notificados de violencia intrafamiliar según sexo a la SE24-2025(*).

Semana Epidemiológica	Mujeres	Hombres	Totales
24	7255	3305	10560

(*) Datos preliminares SE24-2025
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

El gráfico 1, ilustra el comportamiento en términos de tasas de la VIF según sexo, es claro que las mujeres tienen la incidencia más alta siendo la diferencia más amplia en mujeres que en hombres, esta tendencia se ha mantenido a lo largo del tiempo, esto se debe a una combinación de factores históricos, culturales, estructurales y psicológicos, sobre todo por la desigualdad de poder en las relaciones de pareja y familiares, lo cual propicia el uso de la violencia como forma de dominación.

Gráfico 1.
Costa Rica: incidencia de casos notificados de VIF según sexo, SE24-2025 (*) (tasa por 100 000 habitantes).



(*) Datos preliminares SE24-2025
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Grupos de edad

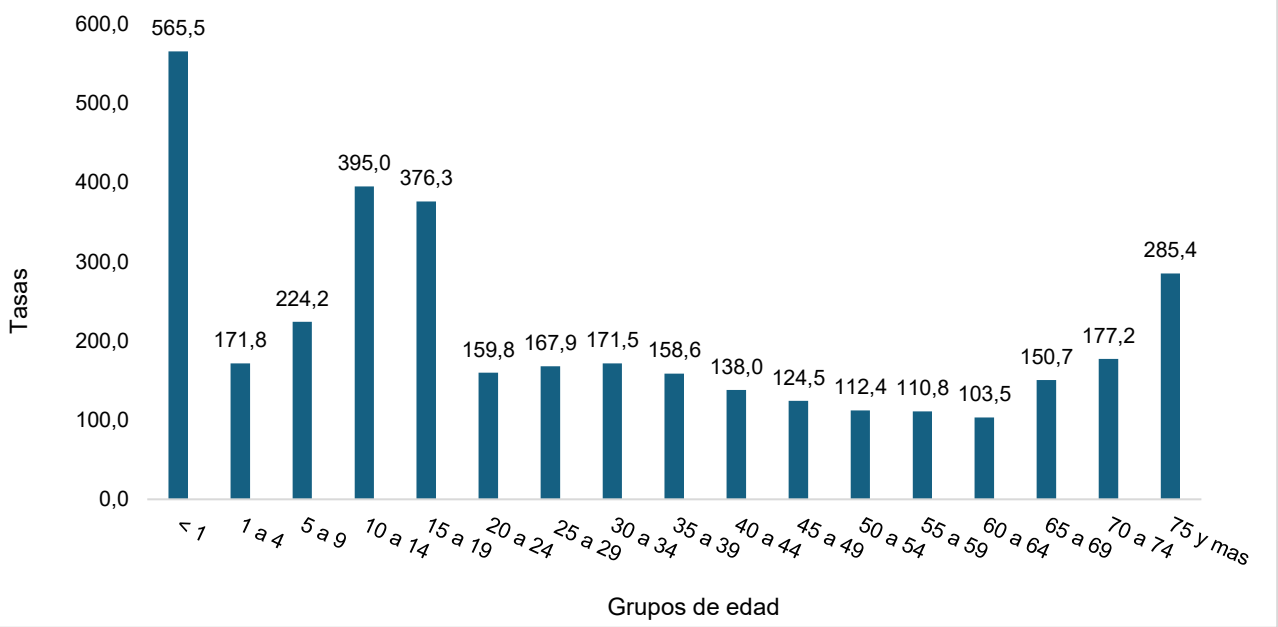
En cuanto a los grupos de edad, en términos de incidencia se mantiene el aumento sostenido en los menores de un año, el gráfico 2 ilustra lo anterior, sobre todo por su vulnerabilidad y dependencia de sus padres o encargados y al no poder defenderse ni pedir ayuda o comunicar las agresiones los convierte en víctimas directa de la violencia por lo que se insiste en la necesidad de redirigir los esfuerzos institucionales hacia estas poblaciones para que la detección temprana y pueda prevenirse evitando mayores riesgos incluso la muerte.

Por otro lado, se mantiene el comportamiento de incremento y de altas tasas de incidencia en la población joven entre los 10 a 14 y 15 a 19 años este último con una tendencia al alza, es importante tomar en consideración que este

comportamiento es multifactorial ya que es una etapa de transición y conflicto generacional en donde están en búsqueda de identidad, autonomía y cuestionamiento de normas, esto puede generar tensiones con figuras de autoridad en el hogar, lo que en algunos casos se traduce en violencia física, verbal o emocional, así mismo son una población vulnerable, dependiente y pueden ser víctimas de abuso sexual por parte de familiares o personas cercanas o bien no tienen acceso a servicios de salud mental, orientación o espacios seguros donde expresar lo que viven. Otros factores importantes son las condiciones socioeconómicas, pobreza, hacinamiento, consumo de sustancias en el hogar o violencia entre adultos indistintamente del estatus que aumentan el riesgo de que los adolescentes sufran o presencien violencia.

Así mismo se mantiene el aumento sostenido de las tasas de violencia en la población adulta mayor con edades superiores a los 75 años y más sobre todo en los hombres, tal y como se ve en el gráfico. Las razones detrás de este fenómeno son múltiples y complejas, principalmente su dependencia física y/o económica sobre todo para su cuidado, alimentación o administración de bienes, la dependencia puede ser aprovechada por cuidadores o familiares para ejercer control, negligencia o abuso, algunos factores como el aislamiento, la soledad o la pérdida de redes de apoyo hacen que las personas mayores sean más vulnerables a la violencia y menos propensas a denunciarla y algunas personas adultas mayores no reconocen ciertas conductas como violencia, especialmente si han vivido en contextos donde el maltrato era normalizado, ciertos problemas de salud mental o deterioro cognitivo pueden aumentar la dependencia y dificultar la comunicación de situaciones de abuso.

Gráfico 2.
Costa Rica: incidencia de casos notificados de VIF según grupos de edad, SE 24-2025 (*) (tasa por 100 000 habitantes).

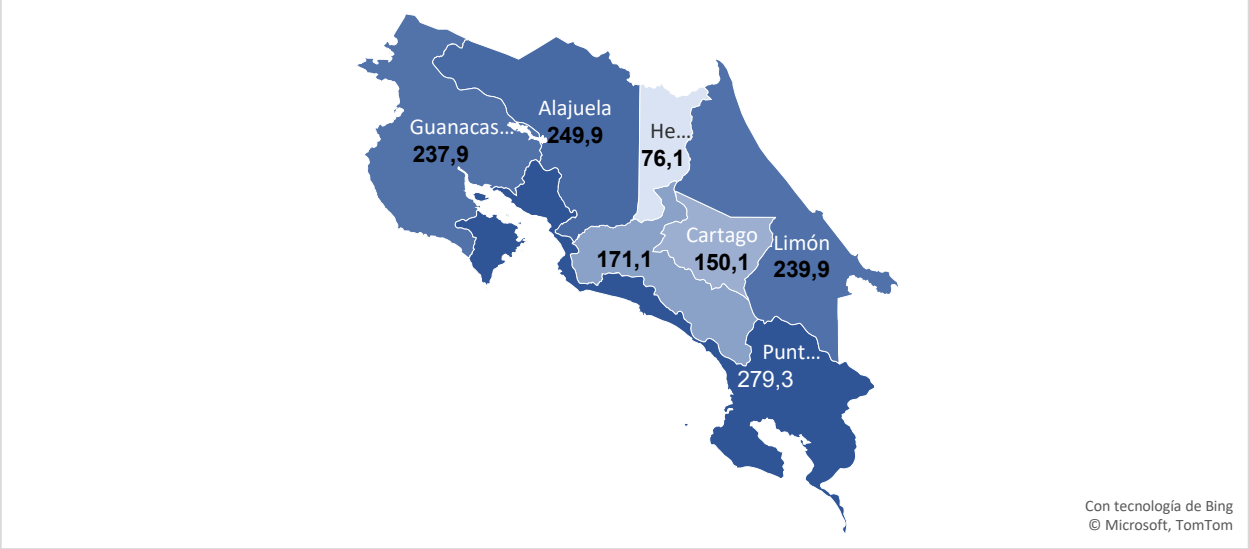


(*) Datos preliminares SE24-2025
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

-Provincias y cantones

El siguiente gráfico evidencia la incidencia de la violencia intrafamiliar a nivel de las provincias según las semanas en mención, en cuanto a esta variable tanto Puntarenas como Alajuela mantienen las tasas más altas, varios son los factores que pueden estar afectando directamente el aumento en estas provincias, entre ellos está el hecho de que en ambas provincias hay zonas con altos índices de pobreza, desempleo y baja escolaridad, condiciones que aumentan el estrés familiar y reducen el acceso a servicios de apoyo, lo que puede favorecer la violencia, además en estos lugares persisten normas tradicionales de género que justifican el control o la subordinación de mujeres, niñas y adolescentes. Un factor preponderante es que, a diferencia de la capital, la cobertura de servicios especializados en violencia intrafamiliar (como oficinas del INAMU, juzgados de violencia doméstica o de salud) es menor en comparación con el Gran Área Metropolitana lo que limita la capacidad de respuesta y seguimiento de los casos, aunque en algunos cantones, el aumento de casos también puede reflejar una mayor conciencia y disposición a denunciar, gracias a campañas locales o presencia de redes comunitarias.

Mapa 1.
Costa Rica: incidencia de casos notificados de VIF por provincia, SE24-2025 (*) (tasa por 100 000 habitantes).

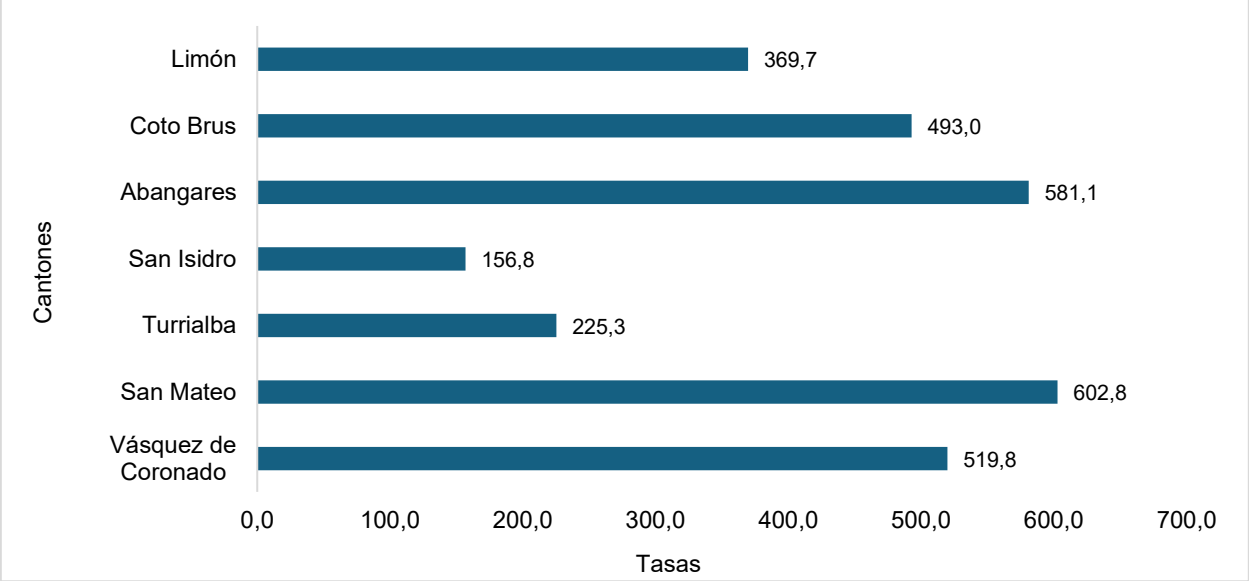


(*) Datos preliminares SE24-2025
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Con relación a los cantones para ambas semanas epidemiológicas, la información del Gráfico 3, indica que San Mateo de Alajuela supera en esta oportunidad al cantón de Coto Brus, seguido de Abangares de Guanacaste y en tercera posición Vásquez de Coronado de San José.

Esto puede deberse a múltiples razones, entre ellas es que San Mateo es uno de los cantones con menor población en el país, esto significa que un número relativamente bajo de casos puede generar una tasa muy alta por cada 100.000 habitantes y aunque es un cantón rural con cierto desarrollo agrícola y turístico, existen sectores con pobreza, desempleo y baja escolaridad, factores que están asociados a un mayor riesgo de violencia intrafamiliar.

Gráfico 3.
Costa Rica: incidencia de casos notificados de VIF por cantón, SE24-2025 (*) (tasa por 100 000 habitantes)



(*) Datos preliminares SE24-2025
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Causas específicas

En lo concerniente a la información de las causas o tipos de violencia según SE 24 indica que, el abuso psicológico es el tipo de violencia con más casos notificados en mujeres, y el abuso físico en los hombres, y a nivel general el abuso físico es el diagnóstico con más casos notificados.

En el caso de las mujeres es una de las formas más comunes de violencia que sufren las mujeres, y hay varias razones entre ellas; las relaciones de poder desiguales han ha colocado históricamente a las mujeres en posiciones de subordinación dentro del hogar y la pareja esto facilita el uso de la violencia psicológica como forma de control, manipulación o castigo emocional, por otro lado se hay una normalización del maltrato emocional y muchas mujeres han sido socializadas para tolerar el maltrato verbal, la humillación o el aislamiento como parte de la vida en pareja o familiar lo que en cierta forma retrasa la identificación del abuso y su denuncia detalle a tomar en consideración sobre todo porque en muchos casos, la violencia psicológica es el primer paso en un ciclo que puede escalar a violencia física o sexual especialmente contra las mujeres.

Por otro lado, en el caso de los hombres muchos de los casos reportados como violencia se genera a través de conflictos o tensiones entre familiares varones, como hermanos, padres e hijos, o incluso entre generaciones (por ejemplo, hijos adolescentes y padres adultos) o bien mediante el castigo físico hacia los hombres menores de edad.

Tabla 2.
Costa Rica: casos notificados de VIF por diagnóstico específico, SE 24-2025 (*).

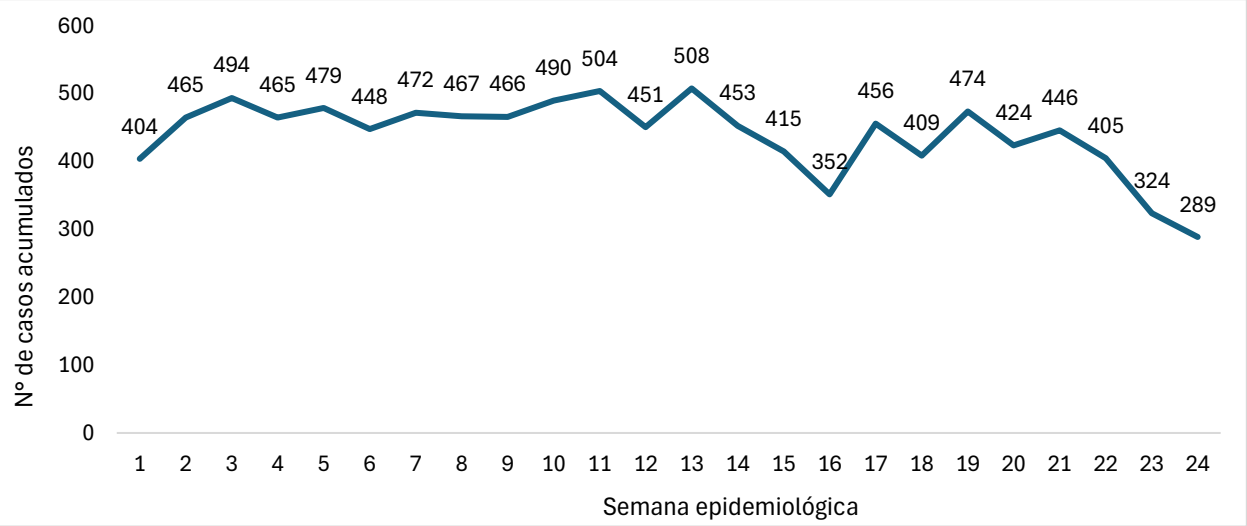
Diagnóstico Específico	Mujeres	Hombres	Total
Abuso físico	1464	1171	***2635***
Abuso psicológico	1658	400	***2058***
Abuso sexual	1381	229	***1610***
Negligencia o abandono	1222	1130	***2352***
Otros síndromes de maltrato (mixtas)	1167	200	***1367***
Síndrome maltrato no especificado	314	166	***480***
Violencia patrimonial	49	9	***58***
Total	***7255***	***3305***	***10560***

(*) Datos preliminares SE24-2025
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

Tendencia

Con respecto a los casos acumulados de VIF la tendencia a la SE24, es estable con una variación en la SE 13 en donde hay un leve aumento, sin embargo, los casos notificados según el acumulado mantienen un comportamiento lineal.

Gráfico 4.
Costa Rica. Tendencia de casos notificados de VIF según semana epidemiológica, a SE 24-2025 (*)



(*) Datos preliminares SE24-2025
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud